

Buku Referensi

TRANSFORMASI PELAYANAN KEBIDANAN

Di Era Digital dan Continuity of Care

Ika Nur Saputri • Margareta Melani
Sri Musfiroh • Yayuk Puji Lestari



BUKU REFERENSI:
TRANSFORMASI PELAYANAN KEBIDANAN
DI ERA DIGITAL DAN *CONTINUITY OF*
CARE

Penulis:

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb
Margareta Melani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes
Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb

Buku Referensi: Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital dan *Continuity of Care*

Penulis:

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb
Margareta Melani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes
Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-09-1

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul *Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital dan Continuity of Care* ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan, khususnya dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan kesehatan yang semakin dinamis, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kesinambungan asuhan.

Pelayanan kebidanan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pelayanan kebidanan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian asuhan secara langsung, tetapi juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, kebutuhan masyarakat modern, serta prinsip pelayanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bidan sebagai tenaga kesehatan profesional perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan agar mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, responsif, dan berpusat pada perempuan.

Buku ini membahas berbagai konsep penting yang menjadi dasar transformasi pelayanan kebidanan, dimulai dari konsep Continuity of Care dalam kebidanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesinambungan asuhan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi. Melalui penerapan Continuity of Care, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat.

Selain itu, buku ini juga menguraikan tentang digital health dan telemidwifery sebagai bagian dari inovasi pelayanan kebidanan di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kebidanan membuka peluang besar untuk meningkatkan akses, efisiensi, komunikasi, edukasi, pencatatan, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Telemidwifery menjadi salah satu bentuk layanan yang dapat mendukung keterjangkauan pelayanan kebidanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki hambatan geografis, waktu, maupun akses terhadap fasilitas kesehatan.

Pembahasan mengenai literasi digital dan kompetensi bidan juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Penguasaan teknologi digital perlu diimbangi dengan kemampuan bidan dalam memilah informasi yang benar, menjaga etika pelayanan, melindungi kerahasiaan data pasien, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, bidan dapat meningkatkan kualitas edukasi, komunikasi, dokumentasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam praktik kebidanan.

Buku ini juga menyoroti model pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia yang diharapkan mampu mengintegrasikan pelayanan konvensional dengan inovasi digital. Model pelayanan tersebut perlu tetap mempertahankan nilai-nilai dasar

kebidanan, seperti empati, komunikasi terapeutik, penghormatan terhadap hak perempuan, pendekatan keluarga, serta pemberian asuhan yang humanis dan berkesinambungan. Transformasi pelayanan kebidanan di Indonesia hendaknya diarahkan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan pemerataan akses, serta mendukung upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

Buku referensi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan kebidanan. Materi yang disajikan diharapkan mampu memperkaya wawasan, meningkatkan pemahaman, dan mendorong lahirnya inovasi dalam praktik kebidanan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku *Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital dan Continuity of Care* ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik kebidanan di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang profesional, adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan ibu dan anak.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP *CONTINUITY OF CARE* DALAM KEBIDANAN 1

A. Pendahuluan.....	1
B. <i>Definisi Continuity Of Care</i>	2
C. <i>Dimensi Continuity of Care</i>	3
D. <i>Tujuan Continuity of Care</i>	5
E. Manfaat <i>Continuity of Care</i>	6
F. Filosofi Kebidanan	7
G. Prinsip <i>Continuity of Care</i>	7
H. Model <i>Continuity Of Care</i>	8
I. Implementasi <i>Continuity Of Care</i>	10
J. Dokumentasi Asuhan	10
K. <i>Continuity of Care</i> Dalam Siklus Kehidupan Perempuan	11
L. Peran Bidan dalam <i>Continuity of Care</i>	25
M. Tantangan dan Strategi dalam <i>Continuity of Care</i>	27
N. Inovasi Digital dalam <i>Continuity of Care</i>	28
O. Penutup.....	30
Referensi.....	32
Glosarium.....	35

BAB 2 *DIGITAL HEALTH* DAN *TELEMIDWIFERY*..... 38

A. Pendahuluan.....	38
B. Konsep <i>Digital Health</i> dalam Kebidanan	39
C. Konsep <i>Telemidwifery</i>	41
D. <i>Evidence-Based Practice</i> dalam <i>Digital Health</i> dan <i>Telemidwifery</i>	43
E. Studi Kasus Implementasi <i>Telemidwifery</i>	44
F. Tantangan Implementasi	46
G. Masa Depan <i>Telemidwifery</i>	47
H. Sintesis dan Implikasi Praktik	48
I. Penutup.....	49
Referensi.....	51
Glosarium.....	52

BAB 3 BUKU LITERASI DIGITAL DAN KOMPETENSI BIDAN 55

A. Pendahuluan.....	55
B. Dasar Teori Dan Konsep Utama.....	56
C. Transformasi Pelayanan Kebidanan Di Era Digital	59
D. Literasi Digital Bidan: Komponen Dan Dimensi.....	61
E. Pengembangan Kompetensi Bidan Di Era Digital.....	64
F. Tantangan Dan Hambatan	66
G. Strategi Dan Inovasi.....	68
H. Simpulan.....	69
Referensi.....	71
Glosarium.....	75

BAB 4 MODEL PELAYANAN KEBIDANAN MASA DEPAN DI INDONESIA 77

A. Pendahuluan.....	77
B. Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital.....	78
C. Continuity of Care sebagai Dasar Pelayanan Kebidanan Masa Depan	80
D. Model Pelayanan Kebidanan Masa Depan di Indonesia	81
E. Kompetensi Bidan Masa Depan	84
F. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kebidanan Masa Depan di Indonesia	84
G. Strategi Penguatan Pelayanan Kebidanan Masa Depan.....	85
H. Penutup.....	86
Referensi.....	87

PROFIL PENULIS 89

BAB 1

KONSEP *CONTINUITY OF CARE* DALAM KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. (P. B. Utami et al., 2020) Dalam praktiknya, pelayanan kebidanan tidak hanya dilakukan secara parsial atau terpisah, tetapi membutuhkan pendekatan yang berkesinambungan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Salah satu pendekatan yang menjadi landasan dalam praktik kebidanan modern adalah *Continuity of Care* (CoC). (Gamble et al., 2020) *Continuity of Care* adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan asuhan kepada perempuan sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga memberikan pelayanan yang holistik dan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Pentingnya *Continuity of Care* didasarkan pada berbagai permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi tantangan, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta fragmentasi pelayanan yang menyebabkan asuhan tidak berkelanjutan. (Hainsworth et al., 2022) Kondisi ini menuntut adanya sistem pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam praktik kebidanan, *Continuity of Care* memberikan kesempatan bagi bidan untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan klien. Hubungan ini memungkinkan bidan untuk memahami kebutuhan individu secara lebih mendalam, memberikan edukasi yang tepat, serta melakukan deteksi dini terhadap risiko atau komplikasi yang mungkin terjadi. Dengan demikian, *Continuity of Care* berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan klien. (Martin et al., 2020)

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan peluang dalam mendukung implementasi *Continuity of Care*, seperti melalui penggunaan rekam medis elektronik, telehealth, dan e-learning dalam pendidikan kebidanan. (R. L. Utami et al., 2021) Hal ini menjadi penting terutama dalam era digital saat ini, di mana pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

mengenai konsep *Continuity of Care* dalam kebidanan, mulai dari dasar teori hingga implementasi dalam praktik. Diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan, dapat memahami pentingnya pendekatan ini serta mampu menerapkannya dalam pelayanan yang profesional, beretika, dan berbasis bukti.(Yani & Yanti, n.d.)

Dengan memahami konsep *Continuity of Care* secara mendalam, diharapkan kualitas pelayanan kebidanan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.(Gamble et al., 2020)

B. Definisi *Continuity Of Care*

Continuity of Care (CoC) atau kesinambungan asuhan merupakan konsep fundamental dalam pelayanan kesehatan yang menekankan pemberian layanan secara berkelanjutan, terkoordinasi, dan konsisten sesuai dengan kebutuhan individu sepanjang waktu. Dalam konteks kebidanan, *Continuity of Care* merujuk pada pemberian asuhan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan secara terus-menerus kepada perempuan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita.(Yani & Yanti, 2019)

Secara umum, *Continuity of Care* dapat didefinisikan sebagai suatu proses pelayanan kesehatan yang terintegrasi, di mana pasien atau klien menerima asuhan yang saling terhubung antar waktu, tempat, dan penyedia layanan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan pelayanan, tetapi juga pada kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan klien yang terjalin secara konsisten. Menurut perspektif pelayanan kesehatan modern, *Continuity of Care* memiliki tiga dimensi utama, yaitu:

1. Kontinuitas Informasi (*Informational Continuity*)

Mengacu pada penggunaan informasi yang relevan mengenai riwayat kesehatan klien untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap konsisten dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam kebidanan, hal ini meliputi pencatatan riwayat kehamilan, persalinan, kondisi kesehatan ibu dan bayi, serta faktor risiko yang mungkin muncul.

2. Kontinuitas Manajemen (*Management Continuity*)

Berkaitan dengan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan kesehatan. Pelayanan yang diberikan harus terkoordinasi dengan baik antar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan dalam asuhan.

3. Kontinuitas Relasional (*Relational Continuity*)

Menekankan pada hubungan berkelanjutan antara klien dan tenaga kesehatan. Dalam praktik kebidanan, hubungan ini sangat penting karena memungkinkan terbentuknya kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan fisik dan emosional klien.

Dalam kebidanan, *Continuity of Care* juga erat kaitannya dengan pendekatan *woman-centered care*, yaitu pelayanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat dari asuhan. Artinya, setiap intervensi yang diberikan mempertimbangkan preferensi, nilai, budaya, dan kebutuhan individu perempuan tersebut. Lebih lanjut, *Continuity of Care* tidak hanya terbatas pada hubungan antara satu bidan dengan satu klien, tetapi juga mencakup koordinasi antar tenaga kesehatan lain, seperti dokter, perawat, dan tenaga gizi, terutama dalam kasus yang memerlukan rujukan atau penanganan lanjutan. Dengan demikian, CoC menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. (Raraningrum & Yunita, 2021)

Penerapan *Continuity of Care* dalam kebidanan memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat deteksi dini komplikasi, meningkatkan kepuasan klien, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. (Moncrieff et al., 2023) Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan sebagai dasar dalam memberikan asuhan yang profesional, holistik, dan berkesinambungan. Dengan demikian, *Continuity of Care* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan pelayanan kebidanan yang menyeluruh, berkelanjutan, terintegrasi, serta berpusat pada perempuan, yang bertujuan untuk menjamin kualitas asuhan dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara optimal. (Adnani et al., 2025)

C. Dimensi *Continuity of Care*

1. Continuity Informasi (Informational Continuity)

Continuity Informasi (Informational Continuity) merupakan salah satu dimensi penting dalam continuity of care yang menekankan pada pemanfaatan informasi pasien secara berkesinambungan dalam setiap tahap pelayanan kesehatan. Dimensi ini mencakup pengumpulan dan penggunaan riwayat kesehatan ibu secara lengkap, meliputi kondisi kehamilan, riwayat penyakit, serta aspek sosial yang dapat memengaruhi kesehatan. Selain itu, dokumentasi catatan medis yang akurat dan sistematis menjadi kunci agar informasi dapat diakses dan dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan juga sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau kehilangan informasi. Dengan demikian, continuity informasi

bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi pasien, sehingga asuhan yang diberikan dapat tepat, aman, dan berkesinambungan.(Asmaningrum et al., 2025)

2. *Continuity Relasional (Relational / Interpersonal Continuity)*

Continuity Relasional (Relational Continuity) merupakan dimensi continuity of care yang menekankan pada hubungan berkelanjutan antara pasien dan tenaga kesehatan dalam proses pelayanan. Dimensi ini ditandai dengan terbangunnya kepercayaan antara ibu dan bidan melalui interaksi yang konsisten dan berkesinambungan. Asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang sama atau oleh tim kecil memungkinkan terciptanya kedekatan emosional serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pasien. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan berpusat pada pasien, sehingga tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dalam praktik kebidanan, dimensi ini sering dikenal sebagai *midwifery continuity of care*, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas asuhan serta kepuasan dan kenyamanan ibu selama masa kehamilan hingga nifas.(Asmaningrum et al., 2025)

3. *Continuity Manajerial (Management Continuity)*

Continuity Manajerial (Management Continuity) merupakan dimensi continuity of care yang menekankan pada konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan kesehatan. Dimensi ini mencakup penyusunan rencana asuhan yang berkesinambungan mulai dari masa antenatal (ANC), intranatal (INC), hingga postnatal (PNC), sehingga pelayanan yang diberikan tetap terarah dan sistematis. Selain itu, kolaborasi antar tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan profesi lainnya menjadi aspek penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pemberian asuhan. Penanganan komplikasi juga dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian, continuity manajerial bertujuan untuk menjamin bahwa asuhan tetap konsisten, terkoordinasi, dan berkualitas, meskipun melibatkan berbagai tenaga kesehatan dalam proses pelayanan.(Asmaningrum et al., 2025)

4. *Continuity Longitudinal (Longitudinal Continuity)*

Continuity Longitudinal (Longitudinal Continuity) merupakan dimensi continuity of care yang menekankan pada kesinambungan pelayanan kesehatan sepanjang waktu dalam siklus kehidupan perempuan. Dimensi ini mencakup pemberian asuhan secara berkelanjutan mulai dari masa remaja, pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan keluarga berencana (KB). Selain itu, pemantauan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara jangka panjang untuk memastikan kondisi kesehatan tetap optimal dan mendeteksi dini adanya

masalah. Dengan demikian, *continuity longitudinal* sangat relevan dengan konsep asuhan kebidanan berkelanjutan, karena memungkinkan pemberian pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perempuan sepanjang daur kehidupannya.(Asmaningrum et al., 2025)

5. *Continuity Tim (Team Continuity)*

Continuity Tim (Team Continuity) merupakan dimensi *continuity of care* yang menekankan pada koordinasi yang efektif antar anggota tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dimensi ini melibatkan kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, ahli gizi, dan profesi lainnya yang saling berkolaborasi sesuai dengan peran dan kompetensinya. Selain itu, sistem rujukan yang efektif menjadi bagian penting untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai tingkat kebutuhannya. Komunikasi yang terstruktur dan jelas antar anggota tim juga diperlukan agar informasi terkait kondisi pasien dapat tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, *continuity tim* bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terintegrasi, efisien, dan berkualitas melalui kerja sama tim yang optimal.(Asmaningrum et al., 2025)

D. Tujuan *Continuity of Care*

Continuity of Care (CoC) dalam kebidanan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap perempuan memperoleh asuhan yang berkesinambungan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhannya sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga pada pengalaman, kepuasan, dan kesejahteraan ibu serta bayi secara menyeluruh.(Raraningrum & Yunita, 2021)

Adapun tujuan *Continuity of Care* dalam kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan

CoC bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dan konsisten, sehingga asuhan yang diberikan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

2. Menjamin kesinambungan asuhan pada setiap tahap kehidupan perempuan

Mulai dari masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita, sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan (*fragmented care*).

3. Meningkatkan keselamatan ibu dan bayi

Dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan, risiko komplikasi dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara cepat dan tepat, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

4. Membangun hubungan terapeutik antara bidan dan klien

CoC memungkinkan terjalinnya hubungan yang berkelanjutan dan penuh kepercayaan, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan kebutuhan klien dapat dipahami secara lebih mendalam.

5. Meningkatkan kepuasan dan pengalaman positif klien

Pelayanan yang berkesinambungan memberikan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi perempuan, sehingga meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kebidanan.

6. Mendorong pemberdayaan perempuan (women empowerment)

CoC memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya, termasuk dalam perencanaan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi.

7. Meningkatkan koordinasi antar tenaga Kesehatan

Pelayanan yang berkesinambungan mendorong adanya kolaborasi yang baik antara bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam sistem rujukan.

8. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya Kesehatan

Dengan perencanaan dan manajemen yang terkoordinasi, CoC dapat mengurangi duplikasi pelayanan serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.

9. Mendukung pencapaian indikator kesehatan nasional dan global

Implementasi CoC berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan kesehatan, seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Secara keseluruhan, tujuan Continuity of Care adalah untuk menciptakan sistem pelayanan kebidanan yang holistik, terintegrasi, dan berpusat pada perempuan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara optimal. (Raraningrum & Yunita, 2021)

E. Manfaat *Continuity of Care*

Continuity of Care (CoC) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam praktik kebidanan. Penerapan CoC memungkinkan tersedianya asuhan yang berkesinambungan, komprehensif, dan berpusat pada pasien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta hubungan

terapeutik antara ibu dan tenaga kesehatan. Selain itu, CoC berkontribusi dalam meningkatkan deteksi dini terhadap risiko dan komplikasi, mempercepat penanganan masalah kesehatan, serta mengurangi kesalahan akibat kurangnya informasi atau koordinasi.(Bradford et al., 2022) Dari sisi hasil kesehatan, *continuity of care* terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperbaiki outcome ibu dan bayi, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Dengan adanya kesinambungan pelayanan, pasien juga lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang tepat, sehingga proses asuhan menjadi lebih efektif, efisien, dan aman.(Fadila et al., 2025)

F. Filosofi Kebidanan

Filosofi Kebidanan merupakan landasan nilai yang menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas adalah proses fisiologis yang alami, sehingga asuhan harus diberikan secara holistik, berpusat pada perempuan, serta menjunjung tinggi kemitraan, empati, dan pemberdayaan melalui informed choice. Filosofi ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep Continuity of Care (CoC), karena kesinambungan asuhan memungkinkan bidan memahami kondisi, kebutuhan, dan preferensi perempuan secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Melalui CoC, hubungan terapeutik yang berkelanjutan dapat terbangun, sehingga meningkatkan kepercayaan, kualitas komunikasi, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, CoC mendukung penerapan asuhan yang konsisten, aman, dan terintegrasi sesuai dengan filosofi kebidanan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta hasil kesehatan ibu dan bayi secara optimal.(E. S. Ningsih et al., 2023)

G. Prinsip *Continuity of Care*

Prinsip Continuity of Care (CoC) menekankan pemberian asuhan yang berkesinambungan, terintegrasi, dan berpusat pada pasien sepanjang siklus kehidupan. Prinsip ini mengutamakan kesinambungan hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga tercipta kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Selain itu, CoC juga menekankan pentingnya kesinambungan informasi melalui pencatatan medis yang akurat serta pertukaran informasi yang baik antar tenaga kesehatan, sehingga setiap tindakan yang diberikan didasarkan pada data yang lengkap dan tepat. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, serta menghargai kebutuhan dan preferensi individu dalam setiap tahap pelayanan.(Sandall et al., 2024)

Prinsip Continuity of Care (CoC):

1. Kesenambungan hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan (relational continuity) untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif
2. Kesenambungan informasi melalui pencatatan medis yang akurat dan komunikasi antar tenaga kesehatan (informational continuity)
3. Pendekatan asuhan yang holistik, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual
4. Pelayanan yang berpusat pada pasien (woman-centered care) dengan menghargai kebutuhan dan preferensi individu
5. Koordinasi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam tim yang terintegrasi
6. Sistem rujukan yang efektif untuk menjamin kelanjutan pelayanan pada tingkat yang lebih tinggi
7. Konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan (*management continuity*)
8. Kesenambungan pelayanan sepanjang siklus kehidupan (longitudinal continuity)
9. Pemberdayaan pasien melalui edukasi dan pengambilan keputusan (informed choice)
10. Menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan

H. Model *Continuity Of Care*

1. Model Midwifery Led Care

Model *Midwifery Led Care* merupakan salah satu model dalam Continuity of Care (CoC) di mana bidan menjadi penanggung jawab utama dalam memberikan asuhan kepada perempuan sepanjang siklus kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan perawatan bayi baru lahir. Model ini menempatkan bidan sebagai pemberi layanan utama bagi ibu dengan kondisi fisiologis (normal), dengan pendekatan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*), serta menekankan hubungan berkelanjutan antara ibu dan bidan. Dalam model ini, asuhan biasanya diberikan oleh satu bidan atau kelompok kecil bidan, sehingga memungkinkan terjalinnya kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan individu pasien. (Sandall et al., 2024)

Midwifery Led Care juga mengedepankan pendekatan minimal intervensi, dukungan emosional, serta pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya (*informed choice*). Model ini tetap didukung oleh sistem rujukan yang jelas dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter spesialis, apabila ditemukan komplikasi atau kondisi risiko tinggi. Dengan demikian, model ini tidak hanya meningkatkan kepuasan ibu terhadap

pelayanan, tetapi juga terbukti berkontribusi dalam meningkatkan outcome kesehatan ibu dan bayi, serta memperkuat implementasi prinsip-prinsip Continuity of Care secara optimal.(Sandall et al., 2024)

2. Model *Shared Care*

Model *Shared Care* merupakan salah satu model dalam Continuity of Care (CoC) yang menekankan pada kolaborasi antara berbagai tenaga kesehatan, seperti bidan, dokter umum, dan dokter spesialis, dalam memberikan asuhan kepada pasien. Dalam model ini, tanggung jawab pelayanan tidak hanya dipegang oleh satu profesi, melainkan dibagi secara terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Asuhan tetap diberikan secara berkesinambungan melalui komunikasi yang efektif, pertukaran informasi yang jelas, serta pembagian peran yang terstruktur antar tenaga kesehatan. Biasanya, model ini digunakan pada kondisi kehamilan dengan risiko tertentu atau ketika diperlukan pemantauan lebih intensif.

Penerapan *Shared Care* memungkinkan pasien memperoleh pelayanan yang komprehensif karena menggabungkan keahlian dari berbagai profesi kesehatan. Meskipun melibatkan lebih dari satu tenaga kesehatan, prinsip kesinambungan tetap dijaga melalui sistem rujukan yang baik, dokumentasi yang lengkap, serta koordinasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, model ini mendukung peningkatan kualitas dan keamanan pelayanan, serta memastikan bahwa setiap keputusan klinis diambil secara tepat sesuai dengan kondisi pasien, sejalan dengan prinsip-prinsip Continuity of Care.

3. Model *Collaborative Care*

Model *Collaborative Care* merupakan salah satu model dalam Continuity of Care (CoC) yang menekankan kerja sama yang lebih erat, setara, dan terintegrasi antar berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Dalam model ini, bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya bekerja secara tim dengan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan klinis, berdasarkan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Berbeda dengan *shared care* yang cenderung berbagi peran secara terpisah, *collaborative care* menekankan interaksi yang intensif, komunikasi dua arah yang berkelanjutan, serta perencanaan asuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penerapan model ini sangat penting terutama pada kasus dengan risiko tinggi atau komplikasi, di mana dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan cepat. Dengan adanya kolaborasi yang efektif, setiap tenaga kesehatan dapat saling melengkapi dalam memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan. Selain itu, model *collaborative care* tetap menjunjung prinsip *woman-centered care* dengan melibatkan pasien dalam proses pengambilan

keputusan. Dengan demikian, model ini tidak hanya meningkatkan koordinasi tim, tetapi juga memperkuat implementasi Continuity of Care dalam mencapai outcome kesehatan ibu dan bayi yang optimal.(Sandall et al., 2024)

I. Implementasi *Continuity Of Care*

Tahapan asuhan dalam implementasi Continuity of Care (CoC) mencakup pemberian pelayanan kebidanan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan perempuan.(Yu et al., 2022)

1. Masa Prakonsepsi, Edukasi kesehatan, skrining, dan persiapan kehamilan untuk memastikan kondisi ibu optimal sebelum hamil
2. Asuhan Kehamilan (Antenatal Care/ANC), Pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala, deteksi dini risiko, serta edukasi kehamilan sehat
3. Asuhan Persalinan (Intranatal Care/INC), Pemberian asuhan persalinan yang aman, nyaman, berpusat pada ibu, serta kesiapan rujukan bila terjadi komplikasi
4. Asuhan Nifas (Postnatal Care/PNC), Pemantauan pemulihan ibu, deteksi tanda bahaya, serta dukungan menyusui
5. Asuhan Bayi Baru Lahir dan Balita, Perawatan bayi, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan pencegahan penyakit
6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Konseling dan pelayanan kontrasepsi untuk perencanaan kehamilan yang sehat dan terencana.

J. Dokumentasi Asuhan

Dokumentasi asuhan dalam Continuity of Care (CoC) merupakan komponen penting yang mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan melalui pencatatan yang sistematis, akurat, dan berkelanjutan. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak pelayanan yang telah diberikan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memastikan bahwa setiap tahap asuhan berjalan secara terintegrasi. Dalam praktik kebidanan, dokumentasi yang baik memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan bayi secara komprehensif dari masa prakonsepsi hingga pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu, dokumentasi asuhan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, peningkatan kualitas pelayanan, serta menjamin aspek legal dan profesional dalam pemberian asuhan yang berkesinambungan. Pencatatan data pasien secara lengkap dan akurat. Dokumentasi asuhan harus mencakup data pasien secara lengkap dan akurat, meliputi identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, serta tindakan yang diberikan. Kelengkapan data ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien. (Raraningrum & Yunita, 2021)

1. Pendokumentasian berkesinambungan pada setiap tahapan asuhan
Setiap tahapan asuhan, mulai dari ANC, INC, PNC, hingga asuhan bayi dan pelayanan KB, harus didokumentasikan secara berkesinambungan. Hal ini memastikan tidak ada informasi yang terlewat dalam proses pelayanan.
2. Penggunaan format dan standar dokumentasi yang baku, dokumentasi dilakukan menggunakan format standar seperti SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning) atau format lain yang sesuai dengan pedoman pelayanan kebidanan. Standarisasi ini memudahkan pemahaman dan konsistensi pencatatan.
3. Mendukung continuity informasi antar tenaga Kesehatan, dokumentasi yang baik berfungsi sebagai media komunikasi antar tenaga kesehatan, sehingga informasi pasien dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian asuhan.
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, data yang terdokumentasi menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan atau intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien.
5. Menjamin aspek legal dan professional
Dokumentasi merupakan bukti tertulis dari asuhan yang telah diberikan, sehingga memiliki nilai hukum dan mencerminkan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.
6. Memudahkan evaluasi dan monitoring asuhan, dokumentasi mempermudah proses evaluasi dan monitoring perkembangan kondisi ibu dan bayi secara berkala, sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

K. Continuity of Care Dalam Siklus Kehidupan Perempuan

1. Remaja
Pada tahap remaja, Continuity of Care (CoC) menekankan pentingnya asuhan promotif dan preventif yang berkesinambungan untuk membentuk dasar kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat di masa depan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, serta berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik remaja.(D. A. Ningsih, 2017)
 - a. Edukasi Kesehatan Reproduksi
Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja merupakan komponen penting dalam Continuity of Care yang bertujuan membentuk pemahaman yang benar sejak dini mengenai fungsi dan perubahan tubuh. Materi yang diberikan mencakup proses pubertas, siklus menstruasi, anatomi dan fisiologi organ reproduksi, serta praktik kebersihan diri yang tepat, seperti personal hygiene saat menstruasi. Selain itu, edukasi juga perlu menyentuh aspek pencegahan, seperti risiko infeksi menular seksual, kehamilan tidak direncanakan, serta

pentingnya menjaga batasan diri dan perilaku sehat. Pendekatan edukasi dilakukan secara komunikatif, sesuai usia, dan sensitif terhadap nilai budaya, sehingga remaja merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Dengan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, remaja diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya secara positif, membangun sikap bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi, serta terhindar dari perilaku berisiko.

b. Pemenuhan Gizi Seimbang

Pemenuhan gizi seimbang pada remaja merupakan aspek penting dalam Continuity of Care karena berperan langsung dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kesiapan kesehatan reproduksi di masa depan. Remaja membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, untuk menunjang aktivitas dan proses perkembangan yang pesat. Edukasi mengenai pola makan sehat perlu diberikan secara berkelanjutan, termasuk kebiasaan sarapan, konsumsi buah dan sayur, serta pembatasan makanan cepat saji. Selain itu, pencegahan anemia menjadi fokus utama, khususnya pada remaja putri, melalui peningkatan konsumsi makanan kaya zat besi dan suplementasi jika diperlukan. Dengan pemenuhan gizi yang optimal, remaja dapat mencapai status kesehatan yang baik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mempersiapkan diri untuk memasuki fase kehidupan reproduksi yang sehat. (D. A. Ningsih, 2017)

c. Pencegahan Perilaku Berisiko

Pencegahan perilaku berisiko pada remaja merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan melindungi kesehatan fisik, mental, dan sosial remaja. Perilaku berisiko seperti pernikahan dini, kehamilan tidak direncanakan, penyalahgunaan zat, serta infeksi menular seksual dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan melalui konseling individu, penyuluhan kelompok, serta pembinaan yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Edukasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan pengambilan keputusan yang sehat. Dengan dukungan yang tepat, remaja diharapkan mampu mengenali risiko, menghindari perilaku yang merugikan, serta mengembangkan gaya hidup yang sehat dan bertanggung jawab. (Raraningrum & Yunita, 2021)

d. Dukungan Psikososial

Dukungan psikososial pada remaja merupakan komponen penting dalam *Continuity of Care* karena masa remaja ditandai dengan berbagai perubahan emosional, sosial, dan identitas diri. Remaja sering menghadapi tekanan dari lingkungan, seperti tuntutan pergaulan, media sosial, serta konflik internal terkait penerimaan diri. Oleh karena itu, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan yang empatik, membangun hubungan yang saling percaya, serta membantu remaja mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan coping yang sehat. Pendekatan yang digunakan harus ramah remaja, tidak menghakimi, dan memberikan ruang bagi remaja untuk mengekspresikan perasaannya. Dengan dukungan psikososial yang berkelanjutan, remaja diharapkan mampu menghadapi perubahan diri dengan lebih positif, menjaga kesehatan mental, serta membangun hubungan sosial yang sehat.

e. Pembentukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pembentukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak masa remaja merupakan bagian penting dalam *Continuity of Care* untuk mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Edukasi yang diberikan mencakup kebiasaan menjaga kebersihan diri, seperti mandi teratur, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta praktik higiene saat menstruasi. Selain itu, remaja juga didorong untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengatur pola istirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan tidak sehat seperti merokok dan konsumsi makanan tidak bergizi. Pembentukan PHBS dilakukan secara berkelanjutan melalui pembiasaan dan keteladanan, sehingga menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan penerapan PHBS yang konsisten, remaja dapat menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan, serta mencegah berbagai penyakit baik jangka pendek maupun jangka panjang. (D. A. Ningsih, 2017)

f. Persiapan Kesehatan Prakonsepsi

Meskipun masih dalam tahap remaja, CoC juga mulai mengarahkan pada kesiapan prakonsepsi di masa depan. Hal ini mencakup pemahaman tentang pentingnya kesehatan sebelum kehamilan, sehingga remaja dapat tumbuh menjadi calon ibu yang sehat.

Selain itu, remaja juga perlu mendapatkan pendampingan psikososial untuk membantu mereka memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, holistik, dan berpusat pada kebutuhan remaja, *Continuity of Care* berperan penting dalam membentuk perilaku hidup

sehat serta meningkatkan kesiapan remaja dalam memasuki masa dewasa dan kehidupan reproduksi yang sehat.

2. Pranikah

Pada tahap pra nikah, *Continuity of Care (CoC)* berfokus pada persiapan kesehatan calon pasangan, khususnya perempuan, untuk memasuki kehidupan pernikahan dan reproduksi yang sehat. Asuhan pada tahap ini bersifat promotif, preventif, dan edukatif, dengan tujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum kehamilan.

a. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kondisi fisik calon pengantin, termasuk status gizi, kesehatan reproduksi, serta deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Hal ini penting untuk mencegah risiko yang dapat memengaruhi kehamilan di masa depan.

b. Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas

Calon pasangan diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, hubungan suami istri yang sehat, serta perencanaan kehamilan. Edukasi ini membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

c. Persiapan Gizi dan Pencegahan Anemia

Optimalisasi status gizi, khususnya pada calon ibu, menjadi fokus penting. Pencegahan anemia melalui edukasi konsumsi zat besi dan pola makan sehat sangat diperlukan untuk mendukung kehamilan yang sehat nantinya.

d. Imunisasi dan Pencegahan Penyakit

Pemberian imunisasi seperti tetanus toxoid (TT) serta edukasi pencegahan penyakit infeksi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan ibu dan calon bayi.

e. Konseling Psikologis dan Kesiapan Mental

Aspek psikologis juga diperhatikan melalui konseling untuk mempersiapkan kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan, peran sebagai pasangan, dan calon orang tua.

f. Perencanaan Kehamilan (*Family Planning*)

Pasangan diberikan informasi mengenai perencanaan kehamilan, termasuk waktu yang tepat untuk hamil serta penggunaan kontrasepsi bila diperlukan, guna mencapai kehamilan yang direncanakan dan sehat.

Melalui pendekatan yang berkesinambungan, *Continuity of Care* pada tahap pra nikah berperan penting dalam memastikan kesiapan calon pasangan secara menyeluruh, sehingga dapat mendukung tercapainya kehamilan yang sehat, aman, dan berkualitas di masa mendatang. (Raraningrum & Yunita, 2021)

3. Kehamilan

Pada tahap kehamilan, *Continuity of Care* (CoC) berfokus pada pemantauan kesehatan ibu dan janin secara berkesinambungan untuk memastikan kehamilan berlangsung normal, sehat, dan aman hingga persalinan. Asuhan yang diberikan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan pendekatan holistik serta berpusat pada kebutuhan ibu.(Asli, 2025)

a. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Teratur

Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) secara teratur merupakan komponen utama dalam Continuity of Care selama masa kehamilan, yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap optimal. Kunjungan ANC dilakukan secara berkala sesuai standar, meliputi pemeriksaan fisik, pemantauan tanda vital, evaluasi pertumbuhan dan perkembangan janin, serta pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Selain itu, ANC juga menjadi sarana untuk mendeteksi secara dini adanya faktor risiko atau komplikasi, seperti anemia, hipertensi, atau gangguan pertumbuhan janin, sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat. Melalui ANC yang berkesinambungan, tenaga kesehatan juga dapat memberikan edukasi, konseling, serta membangun hubungan terapeutik dengan ibu, sehingga meningkatkan kepatuhan kunjungan dan kesiapan menghadapi persalinan.(Tyastuti et al., 2016)

b. Deteksi Dini Risiko dan Komplikasi

Deteksi dini risiko dan komplikasi merupakan bagian penting dalam Continuity of Care selama kehamilan yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin dan komprehensif. Tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi berbagai faktor risiko seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, maupun gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin sejak tahap awal. Proses ini tidak hanya bergantung pada pemeriksaan fisik, tetapi juga didukung oleh anamnesis yang tepat dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. Dengan adanya deteksi dini, intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat, baik melalui penatalaksanaan langsung maupun rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius serta meningkatkan keselamatan ibu dan janin.(Br. Situmorang et al., 2021)

c. Edukasi Kesehatan Kehamilan

Edukasi kesehatan kehamilan merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapan ibu dalam menjalani kehamilan hingga persalinan. Ibu hamil diberikan informasi mengenai perubahan fisiologis dan psikologis selama kehamilan, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta pentingnya melakukan kunjungan

antenatal secara rutin. Selain itu, edukasi juga mencakup persiapan persalinan, perawatan diri, nutrisi, serta perencanaan tempat dan penolong persalinan. Penyampaian edukasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai usia kehamilan, sehingga ibu dapat memahami kondisinya dengan lebih baik dan mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Dengan edukasi yang adekuat, diharapkan ibu menjadi lebih siap, percaya diri, dan aktif dalam menjaga kesehatan dirinya dan janin.

d. Pemenuhan Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil merupakan aspek penting dalam Continuity of Care yang berperan dalam menjaga kesehatan ibu serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Ibu hamil memerlukan asupan nutrisi yang seimbang, meliputi energi, protein, vitamin, dan mineral, yang disesuaikan dengan usia kehamilan. Edukasi mengenai pola makan sehat diberikan secara berkelanjutan, termasuk anjuran konsumsi makanan bergizi, peningkatan asupan zat besi untuk mencegah anemia, serta asam folat untuk mendukung perkembangan sistem saraf janin. Selain itu, suplementasi diberikan sesuai kebutuhan untuk memastikan kecukupan nutrisi. Dengan pemenuhan gizi yang adekuat, risiko komplikasi kehamilan dapat dikurangi dan kesehatan ibu serta janin dapat terjaga dengan baik. (Br. Situmorang et al., 2021)

Kehamilan sering disertai perubahan emosional, sehingga ibu membutuhkan dukungan psikologis dari tenaga kesehatan dan keluarga untuk menjaga kesehatan mental.

e. Persiapan Persalinan dan Komplikasi (*Birth Preparedness*)

Persiapan persalinan dan komplikasi merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga dalam menghadapi proses persalinan secara aman. Ibu dipersiapkan melalui perencanaan tempat bersalin yang sesuai, pemilihan penolong persalinan yang kompeten, serta kesiapan logistik seperti transportasi, biaya, dan pendamping persalinan. Selain itu, edukasi juga mencakup pengenalan tanda-tanda persalinan dan tanda bahaya yang memerlukan penanganan segera. Sistem rujukan yang jelas dan terencana menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan persiapan yang matang, risiko keterlambatan dalam penanganan dapat diminimalkan dan keselamatan ibu serta bayi dapat lebih terjamin. (Br. Situmorang et al., 2021)

f. Pemberdayaan Ibu (*Informed Choice*)

Pemberdayaan ibu melalui *informed choice* merupakan prinsip penting dalam Continuity of Care yang menekankan keterlibatan aktif ibu dalam setiap pengambilan keputusan terkait asuhan yang diterimanya. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami mengenai kondisi, pilihan tindakan, manfaat, serta risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, ibu memiliki kesempatan untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan preferensinya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian ibu dalam menjaga kesehatannya. Melalui pemberdayaan yang berkelanjutan, ibu diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses asuhan, sehingga kualitas pelayanan dan hasil kesehatan menjadi lebih optimal..

Dengan pendekatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, Continuity of Care pada masa kehamilan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan kesehatan ibu dan janin tetap optimal hingga proses persalinan.(Tyastuti et al., 2016)

4. Persalinan

Pada tahap persalinan, Continuity of Care (CoC) berfokus pada pemberian asuhan yang aman, nyaman, dan berkesinambungan untuk memastikan proses persalinan berjalan fisiologis serta meminimalkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Asuhan diberikan secara holistik, berpusat pada ibu, serta didukung oleh hubungan yang telah terjalin sejak masa kehamilan.(Asli, 2025)

a. Asuhan Persalinan Normal (APN)

Asuhan Persalinan Normal (APN) merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang diberikan oleh bidan sesuai dengan standar pelayanan untuk menjamin proses persalinan berlangsung aman dan fisiologis. Bidan melakukan pemantauan kemajuan persalinan secara berkala melalui pemeriksaan klinis yang teratur, termasuk penilaian pembukaan serviks, kontraksi uterus, serta kondisi ibu dan janin. Selain itu, aspek kebersihan dan pencegahan infeksi sangat diperhatikan untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Bidan juga memberikan dukungan fisik dan emosional selama proses persalinan, sehingga ibu merasa nyaman dan percaya diri. Dengan penerapan APN yang tepat, risiko komplikasi dapat diminimalkan serta outcome kesehatan ibu dan bayi dapat lebih optimal.(Ayunda Insani et al., 2019)

b. Pemantauan Kemajuan Persalinan

Pemantauan dilakukan menggunakan alat seperti partograf untuk menilai kemajuan persalinan dan mendeteksi dini adanya penyimpangan.

Pemantauan Kemajuan Persalinan:

- 1) Penggunaan partograf sebagai alat pemantauan, Partograf digunakan untuk mencatat dan memantau kemajuan persalinan secara sistematis dan terstruktur.
- 2) Penilaian pembukaan serviks, Dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemajuan proses persalinan.
- 3) Pemantauan kontraksi uterus, Menilai frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi untuk memastikan persalinan berjalan efektif.
- 4) Pemantauan kondisi janin, Meliputi denyut jantung janin dan kesejahteraan janin selama persalinan.
- 5) Pemantauan kondisi ibu, Meliputi tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan kondisi umum ibu.
- 6) Deteksi dini penyimpangan, Mengidentifikasi adanya hambatan atau komplikasi seperti persalinan lama atau gawat janin.
- 7) Dasar pengambilan keputusan klinis, Hasil pemantauan digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya, termasuk intervensi atau rujukan.

c. Dukungan Fisik dan Emosional

Ibu diberikan dukungan berupa kenyamanan, pengurangan nyeri, serta pendampingan selama proses persalinan untuk meningkatkan rasa aman dan percaya diri. Dukungan Fisik dan Emosional:

- 1) Pemberian kenyamanan selama persalinan, bidan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi ibu selama proses persalinan.
- 2) Manajemen nyeri non-farmakologis, dilakukan melalui teknik seperti relaksasi, pernapasan, pijat, atau perubahan posisi untuk mengurangi rasa nyeri.
- 3) Pendampingan berkelanjutan, ibu didampingi secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan atau keluarga untuk memberikan rasa aman.
- 4) Pemberian dukungan emosional, bidan memberikan motivasi, empati, dan komunikasi yang menenangkan selama persalinan.
- 5) Meningkatkan rasa percaya diri ibu, dukungan yang diberikan membantu ibu merasa lebih yakin dan mampu menjalani proses persalinan.
- 6) Mengurangi kecemasan dan stress, pendekatan yang suportif membantu menurunkan ketegangan emosional selama persalinan.

d. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi

Pencegahan dan penanganan komplikasi merupakan aspek krusial dalam Continuity of Care pada tahap persalinan yang bertujuan menjamin keselamatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan untuk mengenali secara dini tanda-tanda bahaya, seperti perdarahan, partus

lama, gawat janin, atau preeklamsia, melalui pemantauan yang cermat dan berkesinambungan. Upaya pencegahan dilakukan dengan menerapkan standar asuhan yang tepat, menjaga kebersihan, serta melakukan intervensi dini sesuai indikasi. Apabila ditemukan komplikasi, penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur, termasuk stabilisasi awal dan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap bila diperlukan. Koordinasi yang baik antar tenaga kesehatan serta kesiapan sistem rujukan menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan yang optimal. Dengan demikian, risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi dapat diminimalkan. (Noftalina & Riana, 2021)

e. Penerapan Prinsip Asuhan Sayang Ibu dan Bayi

Penerapan prinsip asuhan sayang ibu dan bayi merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang menekankan pelayanan yang manusiawi, aman, dan berpusat pada kebutuhan ibu dan bayi. Asuhan diberikan dengan menghormati hak ibu, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, membuat keputusan, serta memperoleh pelayanan yang bermartabat tanpa diskriminasi. Privasi dan kenyamanan ibu dijaga selama proses persalinan melalui lingkungan yang kondusif dan pendekatan yang empatik. Selain itu, praktik inisiasi menyusui dini (IMD) dan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi segera setelah lahir sangat dianjurkan untuk memperkuat ikatan emosional, menstabilkan kondisi bayi, serta mendukung keberhasilan pemberian ASI. Dengan penerapan prinsip ini, pengalaman persalinan menjadi lebih positif dan berdampak baik terhadap kesehatan ibu dan bayi. (Noftalina & Riana, 2021)

f. Kolaborasi dan Sistem Rujukan

Kolaborasi dan sistem rujukan merupakan komponen penting dalam Continuity of Care yang bertujuan memastikan ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam praktiknya, bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, dan tenaga spesialis untuk memberikan asuhan yang komprehensif, terutama pada kasus dengan risiko atau komplikasi. Apabila kondisi ibu atau bayi memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terencana. Proses rujukan juga harus didukung dengan komunikasi yang efektif, dokumentasi yang lengkap, serta kesiapan transportasi dan fasilitas penerima. Dengan kolaborasi yang baik dan sistem rujukan yang optimal, kesinambungan asuhan tetap terjaga dan keselamatan ibu serta bayi dapat lebih terjamin. (Ayunda Insani et al., 2019)

g. Dokumentasi Asuhan Persalinan

Dokumentasi asuhan persalinan merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan mencatat seluruh tindakan dan perkembangan selama proses persalinan secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan. Setiap hasil pemantauan, intervensi yang dilakukan, respons ibu dan janin, serta kejadian penting selama persalinan harus didokumentasikan secara sistematis menggunakan format yang sesuai, seperti partograf atau catatan SOAP. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai rekam medis, tetapi juga sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan untuk memastikan kesinambungan asuhan. Selain itu, dokumentasi memiliki nilai legal dan menjadi dasar dalam evaluasi serta pengambilan keputusan klinis. Dengan pencatatan yang baik, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan keselamatan ibu serta bayi lebih terjamin. (Ayunda Insani et al., 2019)

Dengan penerapan Continuity of Care pada tahap persalinan, diharapkan proses persalinan berlangsung aman, bermakna, dan memberikan pengalaman positif bagi ibu serta mendukung kesehatan optimal bagi ibu dan bayi.

5. Nifas

Pada masa nifas, *Continuity of Care* (CoC) berfokus pada pemantauan pemulihan kondisi ibu setelah persalinan serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Asuhan diberikan secara berkesinambungan untuk memastikan kesehatan fisik dan psikologis ibu, serta kesejahteraan bayi tetap terjaga. (Rini & Kumala, 2017)

a. Pemantauan Kondisi Ibu Nifas

Pemantauan kondisi ibu nifas merupakan bagian penting dalam Continuity of Care untuk memastikan proses pemulihan pasca persalinan berlangsung normal dan optimal. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap involusi uterus untuk menilai kembalinya ukuran rahim ke kondisi semula, jumlah dan karakteristik perdarahan (lochia), serta tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri, atau bau tidak normal. Kondisi umum ibu seperti tanda vital, status gizi, dan tingkat kelelahan juga diperhatikan. Melalui pemantauan yang komprehensif dan berkesinambungan, tenaga kesehatan dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi, sehingga intervensi dapat segera dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan ibu. (Rini & Kumala, 2017)

b. Dukungan dan Manajemen Laktasi

Dukungan dan manajemen laktasi merupakan bagian penting dalam Continuity of Care pada masa nifas yang bertujuan memastikan keberhasilan pemberian ASI secara optimal. Ibu diberikan pendampingan dalam menyusui,

termasuk teknik menyusui yang benar seperti posisi dan pelekatan bayi, frekuensi menyusui, serta tanda kecukupan ASI. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam mencegah dan menangani masalah laktasi, seperti puting lecet, bendungan ASI, atau mastitis melalui edukasi dan intervensi yang tepat. Edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi juga terus ditekankan sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan imunitas bayi. Dengan dukungan yang berkelanjutan, ibu menjadi lebih percaya diri dalam menyusui dan keberhasilan pemberian ASI dapat tercapai secara optimal. (Sinabariba et al., 2022)

c. Deteksi Dini Komplikasi Nifas

Deteksi dini komplikasi nifas merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan mencegah terjadinya kondisi yang membahayakan ibu setelah persalinan. Tenaga kesehatan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi (misalnya demam, nyeri, atau lochia berbau), serta gangguan psikologis seperti depresi postpartum. Proses deteksi dilakukan melalui pemeriksaan fisik, observasi, serta komunikasi aktif dengan ibu mengenai keluhan yang dirasakan. Dengan adanya deteksi dini, penanganan dapat segera dilakukan secara tepat, baik melalui intervensi langsung maupun rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting untuk menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu serta mendukung proses pemulihan yang optimal.

d. Dukungan Psikologis dan Adaptasi Peran

Dukungan psikologis dan adaptasi peran pada masa nifas merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan membantu ibu menghadapi perubahan emosional serta menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Setelah persalinan, ibu sering mengalami perubahan suasana hati, kelelahan, dan tuntutan baru dalam merawat bayi, sehingga memerlukan pendampingan yang empatik dan berkelanjutan. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan konseling, dukungan emosional, serta menciptakan lingkungan yang suportif dengan melibatkan keluarga. Selain itu, edukasi mengenai perubahan psikologis normal dan tanda-tanda gangguan seperti baby blues atau depresi postpartum juga perlu diberikan. Dengan dukungan yang tepat, ibu diharapkan mampu beradaptasi secara positif, menjaga kesehatan mental, serta membangun ikatan yang baik dengan bayinya. (Ayunda Insani et al., 2019)

e. Edukasi Perawatan Diri dan Bayi

Edukasi perawatan diri dan bayi merupakan bagian penting dalam Continuity of Care pada masa nifas yang bertujuan meningkatkan kemandirian ibu dalam menjaga kesehatan dirinya dan bayinya di rumah. Ibu diberikan informasi mengenai perawatan diri, seperti menjaga kebersihan tubuh, perawatan luka perineum atau luka operasi, serta pentingnya istirahat yang cukup. Selain itu, edukasi juga mencakup pemenuhan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pemulihan dan produksi ASI. Dalam hal perawatan bayi baru lahir, ibu diajarkan cara memandikan bayi, merawat tali pusat, menjaga kehangatan bayi, serta mengenali tanda bahaya pada bayi. Dengan edukasi yang tepat dan berkelanjutan, ibu diharapkan mampu merawat diri dan bayinya secara mandiri, sehingga kesehatan keduanya tetap terjaga secara optimal. (Kostania, 2020)

f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan bagian penting dalam Continuity of Care pada masa nifas yang bertujuan membantu ibu merencanakan kehamilan berikutnya secara sehat dan terencana. Tenaga kesehatan memberikan konseling mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kesesuaian dengan kondisi ibu, terutama bagi ibu menyusui. Selain itu, pelayanan KB juga mencakup pemberian metode kontrasepsi yang aman dan efektif sesuai kebutuhan. Pendekatan ini dilakukan dengan prinsip *informed choice*, sehingga ibu dapat menentukan pilihan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Dengan perencanaan kehamilan yang baik, risiko kehamilan yang terlalu dekat dapat dicegah, serta kesehatan ibu dan anak dapat lebih terjaga. (Widyaningsih et al., 2021)

g. Kunjungan Nifas Berkelanjutan

Kunjungan nifas berkelanjutan merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi ibu dan bayi setelah persalinan. Kunjungan ini memungkinkan tenaga kesehatan menilai proses pemulihan ibu, keberhasilan menyusui, serta pertumbuhan dan adaptasi bayi baru lahir. Selain itu, kunjungan nifas juga menjadi kesempatan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi, memberikan edukasi lanjutan, serta melakukan intervensi yang diperlukan sesuai kondisi ibu dan bayi. Pendekatan yang berkesinambungan ini membantu memastikan bahwa kebutuhan kesehatan ibu dan bayi terpenuhi secara optimal, sehingga dapat mencegah masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup keduanya. (Noftalina & Riana, 2021)

Dengan pendekatan *Continuity of Care*, asuhan pada masa nifas menjadi lebih optimal, terintegrasi, dan mampu mendukung pemulihan ibu serta tumbuh kembang bayi secara menyeluruh.

6. Menopause

Pada tahap menopause, *Continuity of Care* (CoC) berfokus pada pendampingan perempuan dalam menghadapi perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang terjadi akibat penurunan fungsi hormon reproduksi. Asuhan diberikan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas hidup, mencegah komplikasi, serta membantu perempuan beradaptasi dengan fase kehidupan ini secara sehat dan positif. (Asli, 2025)

a. Edukasi tentang Menopause

Edukasi tentang menopause merupakan bagian penting dalam *Continuity of Care* yang bertujuan membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi pada fase ini secara fisik dan psikologis. Perempuan diberikan informasi mengenai proses menopause sebagai kondisi alami akibat penurunan hormon reproduksi, serta berbagai gejala yang mungkin muncul seperti: *Hot flashes*, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan kekeringan vagina. Edukasi juga mencakup cara mengelola gejala melalui perubahan gaya hidup sehat, dukungan sosial, serta pilihan terapi yang tersedia bila diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, perempuan dapat menerima perubahan ini secara positif, mengurangi kecemasan, serta lebih siap dalam menjalani masa menopause dengan kualitas hidup yang tetap optimal. (Nur Anita et al., 2023)

b. Pemantauan Kesehatan Fisik

Pemantauan kesehatan fisik pada masa menopause merupakan bagian penting dalam *Continuity of Care* yang bertujuan menjaga kualitas hidup perempuan seiring dengan meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap berbagai indikator kesehatan, seperti tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi, pemeriksaan kesehatan tulang guna mencegah osteoporosis, serta skrining penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Selain itu, evaluasi status gizi, aktivitas fisik, dan gaya hidup juga menjadi bagian dari pemantauan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, deteksi dini dan intervensi dapat dilakukan secara tepat, sehingga komplikasi dapat dicegah dan kesehatan perempuan tetap terjaga secara optimal. (Nur Anita et al., 2023)

c. Manajemen Gejala Menopause

Manajemen gejala menopause merupakan bagian penting dalam *Continuity of Care* yang bertujuan membantu perempuan mengatasi berbagai keluhan

yang muncul selama masa menopause secara efektif dan berkelanjutan. Tenaga kesehatan berperan dalam mengidentifikasi gejala yang dialami, seperti *hot flashes*, gangguan tidur, perubahan suasana hati, atau kekeringan vagina, kemudian memberikan penatalaksanaan yang sesuai. Pendekatan non-farmakologis meliputi perubahan gaya hidup seperti pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, serta dukungan psikososial. Apabila diperlukan, pendekatan farmakologis seperti terapi hormon dapat diberikan dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Dengan manajemen yang tepat, gejala menopause dapat dikendalikan sehingga kualitas hidup perempuan tetap terjaga dengan baik.(Aulia et al., 2024)

d. Dukungan Psikologis dan Sosial

Dukungan psikologis dan sosial pada masa menopause merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan membantu perempuan menghadapi perubahan emosional dan dinamika sosial yang terjadi. Perubahan hormon seringkali memengaruhi suasana hati, kepercayaan diri, serta hubungan interpersonal, sehingga perempuan membutuhkan pendampingan yang empatik dan berkelanjutan. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan konseling, dukungan emosional, serta membantu perempuan beradaptasi dengan perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial juga penting untuk menciptakan dukungan yang positif. Dengan adanya dukungan yang optimal, perempuan dapat menjalani masa menopause dengan lebih tenang, percaya diri, dan tetap memiliki kualitas hidup yang baik.(Aulia et al., 2024)

e. Promosi Gaya Hidup Sehat

Promosi gaya hidup sehat pada masa menopause merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif. Perempuan didorong untuk menerapkan pola makan seimbang yang kaya akan kalsium, vitamin D, serat, serta rendah lemak jenuh guna mendukung kesehatan tulang dan jantung. Selain itu, aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga ringan hingga sedang sangat dianjurkan untuk menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, serta meningkatkan kesehatan mental. Upaya ini juga disertai dengan anjuran untuk menghindari faktor risiko seperti merokok, konsumsi alkohol, dan stres berlebihan. Dengan penerapan gaya hidup sehat secara konsisten, perempuan dapat menjalani masa menopause dengan kondisi fisik dan psikologis yang lebih optimal.(Aulia et al., 2024)

f. Deteksi Dini Penyakit Degeneratif

Deteksi dini penyakit degeneratif pada masa menopause merupakan bagian penting dalam Continuity of Care yang bertujuan mengidentifikasi secara awal berbagai penyakit yang risikonya meningkat seiring bertambahnya usia dan perubahan hormonal. Skrining dilakukan secara berkala untuk mendeteksi kondisi seperti osteoporosis, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Proses ini dapat meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, profil lipid, serta pemeriksaan kepadatan tulang sesuai indikasi. Dengan deteksi dini, intervensi dapat dilakukan lebih cepat melalui perubahan gaya hidup, terapi medis, maupun pemantauan lanjutan. Hal ini sangat penting untuk mencegah komplikasi, memperlambat progresivitas penyakit, serta menjaga kualitas hidup perempuan tetap optimal di masa menopause.(Aulia et al., 2024)

g. Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan

Pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam masa menopause merupakan bagian penting dari Continuity of Care yang menekankan pemberian asuhan secara menyeluruh dan terus-menerus sesuai kebutuhan perempuan. Asuhan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga perempuan dapat menjalani fase menopause dengan seimbang dan bermakna. Tenaga kesehatan berperan dalam mengintegrasikan berbagai bentuk pelayanan, mulai dari pemantauan kesehatan, konseling, hingga dukungan sosial yang melibatkan keluarga. Pendekatan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dialami perempuan dapat ditangani secara tepat. Dengan demikian, kualitas hidup perempuan pada masa menopause dapat tetap terjaga dan bahkan meningkat.(Aulia et al., 2024)

Dengan penerapan Continuity of Care, perempuan pada masa menopause tetap mendapatkan pelayanan yang optimal, sehingga mampu menjalani fase ini dengan sehat, mandiri, dan berkualitas.

L. Peran Bidan dalam *Continuity of Care*

Bidan memiliki peran sentral dalam implementasi Continuity of Care karena menjadi tenaga kesehatan yang mendampingi perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Peran ini tidak hanya sebagai pemberi asuhan klinis, tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, dan koordinator pelayanan kesehatan.(Asli, 2025)

1. Pemberi Asuhan Komprehensif

Bidan sebagai pemberi asuhan komprehensif memiliki peran utama dalam Continuity of Care dengan memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Asuhan dimulai sejak masa remaja, pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan individu. Dalam setiap tahap, bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga edukasi, konseling, serta dukungan emosional untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Pendekatan yang berkelanjutan ini memungkinkan bidan memahami kondisi pasien secara lebih mendalam, sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih tepat, aman, dan berkualitas.

2. Edukator dan Konselor

Bidan berperan sebagai edukator dan konselor dalam Continuity of Care dengan memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif kepada perempuan dan keluarga di setiap tahap siklus kehidupan. Edukasi yang diberikan mencakup kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu. Selain itu, bidan juga memberikan konseling untuk membantu perempuan memahami kondisi kesehatannya, membuat keputusan yang tepat, serta meningkatkan kemandirian dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif, empatik, dan berkesinambungan sehingga dapat membangun pemahaman yang baik serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam upaya peningkatan kesehatan.

3. Koordinator Pelayanan Kesehatan

Bidan sebagai koordinator pelayanan kesehatan dalam Continuity of Care berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh perempuan di setiap tahap siklus kehidupannya. Bidan mengoordinasikan asuhan dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan spesialis lainnya agar pelayanan yang diberikan bersifat komprehensif dan tepat sasaran. Selain itu, bidan juga memastikan proses rujukan berjalan efektif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, termasuk kesiapan administrasi, komunikasi antar fasilitas, dan kelengkapan informasi pasien. Dengan koordinasi yang baik, kesinambungan pelayanan dapat terjaga sehingga risiko keterlambatan penanganan dapat diminimalkan dan kualitas asuhan menjadi lebih optimal.

4. Advokat bagi Perempuan

Bidan berperan sebagai advokat bagi perempuan dalam Continuity of Care dengan memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan haknya atas

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Dalam praktiknya, bidan membantu perempuan memahami hak-haknya, memberikan informasi yang lengkap dan objektif, serta mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip *informed choice*. Selain itu, bidan juga berperan dalam melindungi perempuan dari tindakan yang tidak sesuai standar atau tidak diinginkan, serta memastikan pelayanan yang diberikan menghormati nilai, budaya, dan martabat perempuan. Melalui peran ini, bidan turut memperkuat posisi perempuan dalam sistem pelayanan kesehatan sehingga mereka lebih berdaya dan terlibat aktif dalam menjaga kesehatannya.

5. Pendukung Hubungan Terapeutik

Bidan berperan sebagai pendukung hubungan terapeutik dalam Continuity of Care dengan membangun interaksi yang berkelanjutan, empatik, dan penuh kepercayaan dengan pasien. Hubungan ini dikembangkan melalui komunikasi yang efektif, keterbukaan, serta sikap menghargai setiap kebutuhan dan pengalaman perempuan di berbagai tahap siklus kehidupannya. Dengan adanya hubungan yang konsisten, bidan dapat memahami kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien secara lebih mendalam, sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih tepat dan personal. Hubungan terapeutik yang kuat juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap anjuran kesehatan serta memperkuat rasa aman dan nyaman selama proses asuhan berlangsung.

M.Tantangan dan Strategi dalam Continuity of Care

Implementasi CoC tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.(Asli, 2025)

Tantangan:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas serta beban kerja yang tinggi dapat menghambat kesinambungan asuhan.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang tidak optimal dapat menyebabkan terputusnya informasi pasien.

3. Akses Pelayanan yang Tidak Merata

Wilayah terpencil sering mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.

4. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Pasien

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelayanan berkelanjutan.

5. Sistem Dokumentasi yang Belum Optimal

Pencatatan yang tidak lengkap atau tidak terintegrasi dapat menghambat CoC.(Fitrayeni et al., 2025)

Strategi:

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

2. Penguatan Sistem Rujukan dan Kolaborasi

Meningkatkan koordinasi antar fasilitas dan tenaga kesehatan.

3. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya CoC.

4. Optimalisasi Sistem Dokumentasi

Menggunakan standar dokumentasi yang baik dan terintegrasi.

5. Pemerataan Akses Pelayanan

Penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil melalui kebijakan dan program pemerintah.

M. Inovasi Digital dalam *Continuity of Care*

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan implementasi CoC menjadi lebih efektif dan efisien.

1. Penggunaan Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record/EMR)

Penggunaan Rekam Medis Elektronik (EMR) merupakan inovasi digital yang sangat penting dalam mendukung *Continuity of Care* karena memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan akses data pasien secara berkelanjutan. Dengan EMR, seluruh informasi kesehatan pasien dapat terdokumentasi secara terintegrasi mulai dari riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, hingga evaluasi asuhan. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses data pasien secara cepat dan akurat di berbagai tingkat pelayanan, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Selain itu, EMR juga membantu mengurangi risiko kehilangan data, duplikasi pencatatan, serta kesalahan informasi. Dengan demikian, penggunaan EMR berkontribusi dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.(Hidayat, 2020)

2. E-Modul dan Media Pembelajaran Digital

E-Modul dan media pembelajaran digital merupakan inovasi dalam *Continuity of Care* yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan maupun mahasiswa kebidanan melalui

pemanfaatan teknologi. Media ini menyediakan materi pembelajaran yang sistematis, interaktif, dan mudah diakses kapan saja, sehingga mendukung proses belajar mandiri maupun pembelajaran terstruktur. Dalam konteks kebidanan, e-modul dapat mencakup materi tentang asuhan kebidanan berkelanjutan, deteksi dini risiko, hingga manajemen kasus di setiap siklus kehidupan perempuan. Selain itu, penggunaan media digital juga memungkinkan pembaruan informasi secara cepat sesuai dengan perkembangan ilmu dan praktik terkini. Dengan demikian, e-modul dan media pembelajaran digital berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang lebih kompeten dan siap menerapkan Continuity of Care secara optimal.(Melani et al., 2025)

3. Telemedicine dan Konsultasi Online

Telemedicine dan konsultasi online merupakan inovasi digital dalam Continuity of Care yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Melalui teknologi ini, perempuan dapat memperoleh layanan kesehatan seperti konsultasi kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan bayi, serta edukasi kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Telemedicine juga membantu meningkatkan akses pelayanan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, komunikasi yang berkelanjutan melalui platform digital mendukung deteksi dini masalah kesehatan serta tindak lanjut yang lebih efektif. Dengan demikian, telemedicine berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.(Hidayat, 2020)

4. Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak

Aplikasi kesehatan ibu dan anak merupakan inovasi digital dalam Continuity of Care yang dirancang untuk mendukung pemantauan kesehatan secara berkelanjutan dan mudah diakses oleh ibu serta tenaga kesehatan. Aplikasi ini membantu memantau perkembangan kehamilan, mencatat hasil pemeriksaan, serta memberikan pengingat jadwal kunjungan antenatal (ANC), imunisasi bayi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur edukasi kesehatan yang berisi informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi, hingga keluarga berencana. Dengan adanya aplikasi ini, ibu menjadi lebih terinformasi, terlibat aktif dalam perawatan kesehatannya, serta lebih patuh terhadap jadwal pelayanan. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kesinambungan asuhan dalam Continuity of Care.(Hidayat, 2020)

5. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Sistem informasi kesehatan terintegrasi merupakan inovasi digital dalam Continuity of Care yang berfungsi menghubungkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu sistem yang saling terkoordinasi. Sistem ini memungkinkan pertukaran data pasien secara cepat, akurat, dan aman antar fasilitas kesehatan, sehingga informasi mengenai riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan adanya integrasi ini, koordinasi antar fasilitas menjadi lebih efektif, mengurangi risiko duplikasi pemeriksaan, serta meminimalkan kesalahan informasi. Selain itu, sistem ini juga mendukung proses rujukan yang lebih cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada pasien dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, sistem informasi kesehatan terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan kesehatan dalam Continuity of Care.(Hidayat, 2020)

N. Penutup

Konsep Continuity of Care (CoC) dalam kebidanan merupakan pendekatan asuhan yang menekankan kesinambungan pelayanan kesehatan secara holistik, komprehensif, dan berpusat pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Mulai dari masa remaja, pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause, CoC memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan pelayanan yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan individu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan.

Melalui penerapan CoC, bidan memiliki peran strategis sebagai pemberi asuhan komprehensif, edukator, konselor, koordinator pelayanan, advokat perempuan, serta pendukung hubungan terapeutik yang berkelanjutan. Dukungan terhadap CoC juga diperkuat dengan model pelayanan kebidanan, tahapan asuhan, dokumentasi yang baik, serta pemanfaatan inovasi digital dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Continuity of Care menjadi fondasi penting dalam praktik kebidanan modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan perempuan dan keluarganya.

Sebagai kesimpulan, implementasi Continuity of Care yang optimal membutuhkan kolaborasi seluruh tenaga kesehatan, dukungan sistem pelayanan, serta pemanfaatan teknologi yang tepat. Dengan komitmen yang kuat, CoC diharapkan mampu menjadi pendekatan utama dalam mewujudkan pelayanan

kebidanan yang aman, bermutu, berkesinambungan, dan berorientasi pada kesejahteraan perempuan di setiap tahap kehidupannya.

Referensi

- Adnani, Q. E. S., Nurfitriyani, E., Merida, Y., Khuzaiyah, S., Okinarum, G. Y., Susanti, A. I., Adepoju, V. A., & Hashim, S. H. (2025). Ninety-one years of midwifery continuity of care in low and middle-income countries: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 25(1), 463.
- Asli, K. (2025). Model Continuity of Care dalam Asuhan Kehamilan dan Persalinan terhadap Pencegahan Stunting: Continuity of Care Model in Pregnancy and Childbirth Care for Stunting Prevention. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Dan Kesehatan (JIBI)*, 3(2), 77–84.
- Asmaningrum, N., Prasetyo, E., & Rifai, A. (2025). Continuity of care pasien dengan penyakit kronis: Sebuah kajian pustaka. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 19(8), 2350–2364.
- Aulia, F., Ulfah, B., Agustina, Y. R., Haryati, I. S., & Aulia, F. (2024). OPTIMALISASI KESEHATAN REPRODUKSI LANSIA MELALUI EDUKASI DAMPAK FISIK DAN PSIKOLOGIS MENOPAUSE. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2(04), 1166–1170.
- Ayunda Insani, A., Bd, Sk., El Sinta, L. B., & Andriani, F. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Persalinan*. www.indomediapustaka.com
- Br. Situmorang, Hilinti, Y., Yulianti, S., Iswari, I., Rahmawati, D. T., Sari, L. Y., & Jumita. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. CV. Pustaka El Queena.
- Bradford, B. F., Wilson, A. N., Portela, A., McConville, F., Fernandez Turienzo, C., & Homer, C. S. E. (2022). Midwifery continuity of care: A scoping review of where, how, by whom and for whom? *PLOS Global Public Health*, 2(10), e0000935.
- Fadila, S. H. I. P., Rahayu, D. E., Titisari, I., & Rahmaningtyas, I. (2025). Asuhan Kebidanan Continuity of Care (CoC) pada Ny."A" Umur 30 Tahun dari Masa Kehamilan Hingga Masa Interval di TPMB Bdn. DS, Pare. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 114–121.
- Fitrayeni, F., Iffah, U., & Ridwan, L. H. (2025). Dampak Continuity Of Care Yang Diberikan Oleh Mahasiswa Kebidanan Terhadap Kepercayaan Perempuan Terhadap Pelayanan Kesehatan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 174–180.
- Gamble, J., Sidebotham, M., Gilkison, A., Davis, D., & Sweet, L. (2020). Acknowledging the primacy of continuity of care experiences in midwifery education. *Women and Birth*, 33(2), 111–118.
- Hainsworth, N., Dowse, E., Cummins, A., Ebert, L., & Foureur, M. (2022). Heutagogy: A self-determined learning approach for Midwifery Continuity of Care experiences. *Nurse Education in Practice*, 60, 103329.

- Hidayat, F. (2020). *Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*. Deepublish.
- Hill, K. (1996). The demography of menopause. *Maturitas*, 23(2), 113–127.
- Kostania, G. (2020). Model Pelaksanaan dan Evaluasi Asuhan Kebidanan Berkesinambungan dalam Praktik Kebidanan Prodi D. IV Kebidanan. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 5(1), 1–13.
- Martin, C. J. H., MacArthur, J., Martin, C. R., & McInnes, R. J. (2020). Midwives' views of changing to a Continuity of Midwifery Care (CMC) model in Scotland: a baseline survey. *Women and Birth*, 33(5), e409–e419. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519219303750>
- Melani, M., Sutedja, E., Irianti, S., Herawati, D. M. D., & Pramatirta, A. Y. (2025). Development of a website-based E-module for midwifery care for neonates, infants, and toddlers: A mixed-method study. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101993. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101993>
- Moncrieff, G., Martin, C. H., Norris, G., & MacVicar, S. (2023). "It's no ordinary job": Factors that influence learning and working for midwifery students placed in continuity models of care. *Women and Birth*, 36(3), e328–e334.
- Ningsih, D. A. (2017). Continuity Of Care Kebidanan. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(2), 67–77.
- Ningsih, E. S., Mayasari, B., ST, S., Susiyanti, B. E., ST, S., Ramli, N., SiT, S., Anggraeni, W., ST, S., & Nur, A. (2023). *Konsep Kebidanan*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Noftalina, E., & Riana, E. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Polita Press. <http://repository.polita.ac.id/id/eprint/312/1/PENDAHULUAN.pdf>
- Nur Anita, S. S. T., Raehan, S., Fitriani Mediastuti, S. S. I., Retno Heru Setyorini, S. S. T., Desi Ekawati, S. S. T., Dian Nurafifah, S. S. T., Silvia Yolanda, S., Lilin Turlina, S. S. T., Ricca Rizkiwita, S., & Leza Fidyah Restiana, S. S. T. (2023). *Asuhan Kebidanan Remaja & Menopause*. Kaizen Media Publishing.
- Raraningrum, V., & Yunita, R. D. (2021). Analisis Implementasi Continuity of Care (COC). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 8(1), 11–20.
- Rini, S., & Kumala, F. (2017). *Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice*. Deepublish.
- Sandall, J., Fernandez Turienzo, C., Devane, D., Soltani, H., Gillespie, P., Gates, S., Jones, L. V., Shennan, A. H., & Rayment-Jones, H. (2024). Midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing

- women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>
- Sinabariba, M., Sinaga, D., & Marsalena, R. (2022). Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Post Partum Blues di Klinik Pratama SAM Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021. *HealthCaring: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(1), 18–26.
- Tyastuti, S., Wahyuningsih, H. P., SiT, S., Keb, M., Wahyuningsih, H. P., SiT, S., & Keb, M. (2016). *Asuhan kebidanan kehamilan*. Kementerian Kesehatan RI. <https://eprints.triatmamulya.ac.id/1353/1/17.%20Asuhan%20Kebidanan%20Kehamilan.pdf>
- Utami, P. B., Irfan, I., & Noorbaya, S. (2020). Efektivitas Metode Pembelajaran Continuity Of Care Terhadap Peningkatan Kompetensi Pemberian Asuhan Kebidanan. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 3(2), 101–108.
- Utami, R. L., Febriani, W., & Ginting, N. B. B. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kebidanan dalam Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Multidisiplin Paradigma Journal*, 1(1), 11–15.
- Widyaningsih, S., Kes, M., & Nababan, L. (2021). *Modul Praktikum KB dan Pelayanan Kontrasepsi Modul Pratikum KB dan Pelayanan Kontrasepsi*. <http://repository.stikessaptabakti.ac.id/176/1/12.%20MODUL%20PRAKTIKUM%20KB%20DAN%20PELAYANAN%20KONTRASEPSI%20%281%29-dikonversi-dikonversi%20%281%29%281%29.pdf>
- Yani, L. Y., & Yanti, A. D. (n.d.). *THE INFLUENCE OF CONTINUITY OF CARE (COC) TO THE INCREASING OF COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR ASPECTS OF MIDWIFERY CARE TO STUDENTS OF MIDWIFERY STUDY PROGRAM*.
- Yani, L. Y., & Yanti, A. D. (2019). The the Influence of Continuity of Care (Coc) to the Increasing of Cognitive, Affective and Psychomotor Aspects of Midwifery Care to Students of Midwifery Study Program. *INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING AND MIDWIFERY SCIENCE (IJNMS)*, 3(2), 80–88.
- Yu, J. A., Cook, S., Imming, C., Knezevich, L., Ray, K., Houtrow, A., Rosenberg, A. R., & Schenker, Y. (2022). A Qualitative Study of Family Caregiver Perceptions of High-Quality Care at a Pediatric Complex Care Center. *Academic Pediatrics*, 22(1), 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2021.05.012>

Glosarium

A

Antenatal Care (ANC): Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin.

Asuhan Kebidanan: Pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan kepada perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksi.

B

Bidan: Tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan.

C

Continuity of Care (CoC): Pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan asuhan secara terintegrasi sepanjang siklus kehidupan perempuan.

Collaborative Care: Model pelayanan kesehatan berbasis kerja sama tim antar profesi secara terintegrasi.

D

Deteksi Dini: Upaya menemukan secara awal adanya risiko atau komplikasi kesehatan.

Dokumentasi Asuhan: Pencatatan sistematis dan berkelanjutan terkait pelayanan yang diberikan kepada pasien

E

E-Module (E-Modul): Media pembelajaran digital berbasis elektronik yang dapat diakses secara online.

Electronic Medical Record (EMR): Sistem pencatatan rekam medis pasien dalam bentuk digital.

F

Family Planning (KB): Upaya perencanaan kehamilan melalui penggunaan metode kontrasepsi.

H

Holistik: Pendekatan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual secara menyeluruh

I

Informed Choice: Proses pengambilan keputusan oleh pasien berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas.

Intranatal Care (INC): Asuhan yang diberikan selama proses persalinan.

K

Kolaborasi: Kerja sama antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Komprehensif: Pelayanan yang menyeluruh dan mencakup semua aspek kebutuhan pasien.

L

Longitudinal Continuity: Kesenambungan pelayanan kesehatan dalam jangka panjang sepanjang siklus kehidupan.

M

Manajemen Kontinuitas (Management Continuity): Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Midwifery Led Care: Model pelayanan di mana bidan menjadi penanggung jawab utama asuhan.

N

Nifas (Postnatal Care/PNC): Masa setelah persalinan hingga organ reproduksi kembali seperti semula.

P

Partograf: Alat untuk memantau kemajuan persalinan secara sistematis.

Prakonsepsi: Masa sebelum terjadinya kehamilan.

Promotif: Upaya meningkatkan kesehatan.

Preventif: Upaya pencegahan penyakit.

R

Relational Continuity: Hubungan berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan pasien.

Rujukan: Proses pengalihan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

S

Shared Care: Model pelayanan yang melibatkan beberapa tenaga kesehatan dengan pembagian peran.

Sistem Informasi Kesehatan: Sistem yang mengelola data dan informasi kesehatan secara terintegrasi.

T

Telemedicine: Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital.

W

Woman-Centered Care: Pendekatan pelayanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan dengan menghargai kebutuhan, nilai, dan preferensinya.

BAB 2

DIGITAL HEALTH DAN TELEMIDWIFERY

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor kesehatan telah berkembang menjadi pilar strategis dalam meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan secara global (World Health Organization [WHO], 2023). Perkembangan ini tidak hanya mengubah mekanisme penyampaian layanan, tetapi juga mereformasi sistem kesehatan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pasien. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, tantangan klasik seperti keterbatasan akses geografis, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta disparitas kualitas layanan masih menjadi hambatan utama, khususnya di negara berkembang (United Nations Children's Fund [UNICEF], 2023). Kondisi ini menuntut adanya inovasi yang mampu menjembatani kesenjangan layanan sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan maternal secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, konsep digital health hadir melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mobile health (mHealth), telemedicine, artificial intelligence (AI), dan sistem informasi kesehatan terintegrasi (OECD, 2023). Dalam praktik kebidanan, perkembangan ini melahirkan konsep telemidwifery, yaitu pemberian asuhan kebidanan berbasis teknologi digital yang memungkinkan interaksi antara bidan dan pasien tanpa batasan ruang dan waktu (Smith et al., 2024). Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelayanan maternal mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki health outcomes ibu dan bayi, serta mendukung deteksi dini risiko kehamilan (Lee et al., 2025). Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pemantauan kondisi ibu secara real-time, konsultasi jarak jauh, serta penyediaan edukasi kesehatan yang lebih personal dan berkelanjutan, sehingga memperkuat implementasi continuity of care dalam praktik kebidanan modern (Johnson et al., 2024).

B. Konsep *Digital Health* dalam Kebidanan

Digital health merupakan integrasi teknologi digital ke dalam sistem kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi sistem, serta health outcomes pada tingkat individu maupun populasi (World Health Organization [WHO], 2023). Konsep ini tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma pelayanan kesehatan menjadi lebih berbasis data, terintegrasi, dan berpusat pada pasien. Dalam konteks kebidanan, digital health mencakup berbagai komponen utama seperti mobile health (mHealth), telemedicine, electronic health records (EHR), serta penggunaan wearable devices yang memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara kontinu (OECD, 2023). Dengan demikian, digital health berperan sebagai enabler dalam mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti.

Implementasi digital health dalam pelayanan kebidanan telah menunjukkan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku kesehatan ibu. Penggunaan mHealth, misalnya, terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap kunjungan antenatal care, memperkuat edukasi kesehatan, serta mendukung pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes gestasional secara lebih efektif (Kim et al., 2024). Selain itu, integrasi teknologi wearable devices memungkinkan pemantauan parameter fisiologis seperti tekanan darah, denyut jantung, dan aktivitas harian secara real-time, sehingga meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap risiko komplikasi kehamilan (Garcia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa digital health tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sistem preventif yang memperkuat upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kebidanan.

Dalam kerangka pelayanan kebidanan, digital health diimplementasikan melalui pendekatan continuum of care yang mencakup seluruh siklus kehidupan reproduksi perempuan, mulai dari prakonsepsi hingga masa postpartum (WHO, 2023). Pada fase prakonsepsi, teknologi digital dimanfaatkan untuk edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta skrining risiko awal secara mandiri (United Nations Children's Fund [UNICEF], 2023). Selanjutnya, pada fase antenatal, aplikasi kesehatan dan layanan telekonsultasi memungkinkan pemantauan kondisi ibu secara berkelanjutan, termasuk deteksi dini komplikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap intervensi medis (Lee et al., 2025). Pendekatan ini memperkuat peran ibu sebagai subjek aktif dalam pengelolaan kesehatannya sendiri.

Pada fase intrapartum dan postpartum, digital health berperan dalam meningkatkan koordinasi layanan dan keberlanjutan asuhan kebidanan. Sistem

rujukan digital memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat, sehingga meningkatkan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan (World Bank, 2023). Sementara itu, pada periode postpartum, teknologi digital mendukung layanan seperti telelaktasi, pemantauan kesehatan mental ibu, serta edukasi perawatan bayi secara berkelanjutan melalui platform digital (Johnson et al., 2024). Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa digital health mampu meningkatkan integrasi layanan kesehatan maternal secara komprehensif, sekaligus memperkuat implementasi *continuity of care* dalam praktik kebidanan modern (OECD, 2023).

Selain memberikan manfaat dalam aspek klinis, digital health juga berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem pelayanan kebidanan melalui optimalisasi manajemen data dan alur kerja pelayanan. Penggunaan electronic health records (EHR) memungkinkan pencatatan data pasien yang lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan lintas fasilitas. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan medis akibat keterbatasan informasi, tetapi juga meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan. Dengan demikian, digital health berkontribusi dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pasien (World Health Organization [WHO], 2023).

Di sisi lain, pemanfaatan digital health juga membuka peluang dalam penguatan peran pasien sebagai aktor utama dalam pengelolaan kesehatannya. Melalui akses terhadap informasi kesehatan yang lebih luas dan interaktif, ibu hamil dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemantauan kondisi kesehatannya, pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap intervensi medis. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *patient-centered care*, di mana pasien tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai mitra dalam proses pelayanan kesehatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan *self-efficacy*, kepatuhan terapi, serta hasil kesehatan yang lebih baik (Kim et al., 2024).

Namun demikian, optimalisasi digital health dalam pelayanan kebidanan memerlukan kesiapan sistem yang komprehensif, baik dari aspek teknologi, sumber daya manusia, maupun kebijakan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital tenaga kesehatan dan pasien, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tanpa dukungan tersebut, pemanfaatan digital health berpotensi tidak maksimal dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam

kebidanan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak (OECD, 2023).

C. Konsep *Telemidwifery*

Telemidwifery merupakan bentuk inovasi dalam praktik kebidanan yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk memberikan asuhan secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas pelayanan (Smith et al., 2024). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan akses layanan kesehatan ibu, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis. Ruang lingkup telemidwifery mencakup berbagai layanan, mulai dari konsultasi klinis, edukasi kesehatan, pemantauan kehamilan, hingga konseling psikososial yang dilakukan melalui platform digital (Brown et al., 2023). Dengan demikian, telemidwifery tidak hanya berfungsi sebagai alternatif layanan, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan kebidanan.

Secara konseptual, telemidwifery mengadopsi pendekatan holistik yang berfokus pada kebutuhan perempuan secara menyeluruh, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial budaya (Taylor et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan (*woman-centered care*), sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mempertimbangkan konteks kehidupan pasien. Selain itu, telemidwifery mendukung implementasi pelayanan berkelanjutan (*continuity of care*), di mana hubungan antara bidan dan pasien tetap terjaga sepanjang siklus reproduksi, meskipun dilakukan melalui media digital (Lee et al., 2025). Hal ini memperkuat kualitas hubungan terapeutik dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam perspektif sistem kesehatan, telemidwifery merupakan bagian integral dari ekosistem digital health yang menghubungkan berbagai komponen layanan secara terintegrasi. Implementasi telemidwifery memungkinkan terjadinya pertukaran informasi kesehatan secara cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih responsif dan berbasis data. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time, yang sangat penting dalam mendeteksi dini risiko komplikasi kehamilan. Dengan demikian, telemidwifery berperan sebagai jembatan antara pelayanan konvensional dan pelayanan berbasis teknologi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Keberhasilan implementasi telemidwifery sangat bergantung pada integrasi beberapa komponen utama, yaitu platform digital yang andal, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi digital, sistem komunikasi yang efektif, serta ketersediaan

data kesehatan yang terintegrasi (World Health Organization [WHO], 2023). Selain itu, aspek keamanan dan privasi data menjadi isu krusial yang harus diperhatikan dalam setiap interaksi digital antara tenaga kesehatan dan pasien (OECD, 2023). Perlindungan data kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan yang digunakan.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur jaringan dan tingkat literasi digital pengguna juga menjadi determinan penting dalam keberhasilan telemidwifery (International Telecommunication Union [ITU], 2023). Keterbatasan akses internet dan rendahnya kemampuan penggunaan teknologi dapat menghambat optimalisasi layanan digital, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, interaksi antara teknologi, tenaga kesehatan, dan sistem organisasi menciptakan kompleksitas tersendiri dalam implementasi telemidwifery, sehingga diperlukan pendekatan sistem yang komprehensif dalam perencanaan dan pelaksanaannya (Garcia et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan telemidwifery tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kebijakan pendukung yang berkelanjutan.

Selain aspek pelayanan klinis, telemidwifery juga berperan dalam memperkuat fungsi edukasi kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Melalui platform digital, bidan dapat memberikan informasi kesehatan yang terstruktur, interaktif, dan mudah diakses oleh pasien kapan saja. Edukasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perawatan kehamilan, persiapan persalinan, perawatan bayi baru lahir, hingga kesehatan reproduksi jangka panjang. Pendekatan edukasi berbasis digital memungkinkan penyampaian informasi yang lebih konsisten dan berulang, sehingga meningkatkan pemahaman pasien serta mendorong perubahan perilaku kesehatan yang lebih positif (Brown et al., 2023).

Lebih lanjut, telemidwifery juga membuka peluang dalam penguatan sistem rujukan dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Melalui integrasi platform digital, komunikasi antara bidan, dokter, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus dengan risiko tinggi yang memerlukan penanganan lintas disiplin. Dengan adanya sistem komunikasi yang terintegrasi, proses rujukan menjadi lebih terkoordinasi, sehingga dapat meminimalkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi (World Health Organization [WHO], 2023).

Di sisi lain, pemanfaatan telemidwifery juga memberikan kontribusi dalam penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan. Data yang dihasilkan dari interaksi digital antara tenaga kesehatan dan pasien dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menilai kualitas pelayanan, mengidentifikasi tren kesehatan, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Analisis data ini

memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) yang lebih akurat dan terukur. Dengan demikian, telemidwifery tidak hanya berfungsi pada tingkat individu, tetapi juga memberikan dampak pada penguatan sistem kesehatan secara makro (OECD, 2023).

Namun demikian, pengembangan telemidwifery di masa depan memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Inovasi teknologi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta regulasi yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa implementasi telemidwifery tetap mempertahankan nilai-nilai humanistik dalam pelayanan kebidanan, seperti empati, komunikasi terapeutik, dan pendekatan berbasis kebutuhan pasien. Dengan pendekatan yang seimbang antara teknologi dan aspek kemanusiaan, telemidwifery dapat berkembang sebagai model pelayanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas hidup ibu dan anak (Taylor et al., 2024).

D. Evidence-Based Practice dalam Digital Health dan Telemidwifery

Pendekatan evidence-based practice dalam digital health dan telemidwifery menekankan penggunaan bukti ilmiah terkini untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang efektif dan aman. Integrasi teknologi digital dalam pelayanan kebidanan tidak hanya didasarkan pada inovasi, tetapi juga pada hasil penelitian empiris yang menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan maternal. Oleh karena itu, implementasi digital health harus mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan kebutuhan pasien dan sistem kesehatan secara luas.

Dalam aspek peningkatan akses dan utilisasi layanan, berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi digital seperti SMS reminder, aplikasi kesehatan, dan telekonsultasi mampu meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kunjungan antenatal care secara signifikan (Kim et al., 2024). Teknologi ini berperan dalam mengurangi hambatan akses, terutama bagi ibu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, telehealth memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan tanpa batasan geografis dan waktu, sehingga memperluas jangkauan layanan kebidanan dan meningkatkan pemerataan akses kesehatan maternal (Taylor et al., 2024). Dengan demikian, digital health berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah.

Dari perspektif outcome kesehatan, digital health terbukti memberikan dampak positif terhadap deteksi dini dan pencegahan komplikasi kehamilan. Monitoring berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi dan perangkat digital,

memungkinkan pengumpulan data kesehatan secara real-time yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko lebih awal (Lee et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan teknologi juga meningkatkan pengelolaan penyakit kronis pada ibu hamil, seperti hipertensi dan diabetes gestasional, melalui pemantauan yang lebih terstruktur dan respons klinis yang lebih cepat (Garcia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa digital health tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan ibu dan bayi.

Intervensi digital juga berperan penting dalam meningkatkan praktik kesehatan ibu, khususnya dalam keberhasilan menyusui eksklusif. Edukasi berbasis aplikasi dan telekonseling memungkinkan ibu memperoleh informasi yang akurat dan dukungan yang berkelanjutan, bahkan setelah keluar dari fasilitas kesehatan (Johnson et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan ibu, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dalam praktik menyusui. Dengan demikian, digital health menjadi sarana efektif dalam mendukung intervensi promotif dan preventif yang berkelanjutan dalam pelayanan kebidanan.

Dalam aspek kepuasan pasien dan kualitas pelayanan, penggunaan telemidwifery menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pengalaman pasien. Fleksibilitas layanan, kemudahan akses, serta komunikasi yang lebih intensif antara bidan dan pasien menjadi faktor utama yang meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan yang diterima (Kim et al., 2024). Selain itu, telemidwifery memungkinkan pelayanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan individu pasien, sehingga meningkatkan kualitas hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa interaksi digital belum sepenuhnya dapat menggantikan kebutuhan akan interaksi tatap muka dalam praktik kebidanan, terutama dalam situasi yang membutuhkan pemeriksaan fisik atau dukungan emosional yang lebih intensif (Brown et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang paling optimal adalah model hybrid care, yaitu kombinasi antara layanan digital dan tatap muka. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan keunggulan teknologi tanpa mengabaikan aspek humanistik dalam pelayanan kebidanan, sehingga menghasilkan layanan yang lebih komprehensif, efektif, dan berpusat pada pasien.

E. Studi Kasus Implementasi *Telemidwifery*

Implementasi telemidwifery dalam praktik kebidanan memberikan ilustrasi konkret mengenai peran strategis teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan maternal. Salah satu bentuk implementasi yang banyak dikaji adalah telelaktasi berbasis komunikasi digital, di mana bidan memberikan edukasi,

pendampingan, serta pemantauan kepada ibu postpartum secara berkelanjutan melalui platform daring. Melalui pendekatan ini, ibu dapat mengakses informasi terkait teknik menyusui, manajemen laktasi, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi secara real-time. Pendekatan tersebut tidak hanya terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif, tetapi juga memperkuat dukungan emosional dan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya (Johnson et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu memperluas peran bidan dalam memberikan asuhan yang bersifat edukatif dan suportif secara kontinu.

Pada kelompok ibu hamil dengan risiko tinggi, pemanfaatan aplikasi berbasis digital menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pemantauan kesehatan. Ibu hamil dapat secara mandiri mencatat parameter kesehatan penting seperti tekanan darah, kadar glukosa, serta aktivitas harian, yang selanjutnya dipantau oleh tenaga kesehatan secara jarak jauh. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi komplikasi, seperti preeklamsia atau diabetes gestasional, sehingga intervensi klinis dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat (Lee et al., 2025). Dengan demikian, telemidwifery tidak hanya meningkatkan akses terhadap pelayanan, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dan responsif dalam menjaga keselamatan ibu dan janin.

Lebih lanjut, integrasi digital health dalam telemidwifery berfungsi sebagai sistem early warning yang efektif dalam pelayanan kebidanan modern. Pemanfaatan data kesehatan secara real-time memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi perubahan kondisi pasien secara lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Hal ini berimplikasi pada peningkatan ketepatan pengambilan keputusan klinis yang berbasis data dan bukti ilmiah, sehingga mampu menurunkan risiko terjadinya komplikasi yang lebih berat (Garcia et al., 2023). Dengan kata lain, teknologi digital tidak hanya mendukung proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan pasien (patient safety) secara menyeluruh.

Temuan empiris dari studi internasional semakin memperkuat efektivitas telemidwifery dalam praktik kebidanan. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Medical Internet Research* menunjukkan bahwa intervensi mobile health (mHealth) berbasis aplikasi smartphone secara signifikan meningkatkan kepatuhan kunjungan antenatal care serta menurunkan risiko komplikasi kehamilan melalui fitur pengingat, edukasi personal, dan komunikasi langsung dengan tenaga kesehatan (Kim et al., 2024). Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif pasien (patient engagement) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan intervensi digital, sekaligus memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis pencegahan.

Selain itu, studi multi-negara yang dipublikasikan dalam *The Lancet Digital Health* menunjukkan bahwa implementasi telemidwifery melalui telehealth mampu

meningkatkan akses layanan kesehatan maternal hingga lebih dari 30%, serta mengurangi keterlambatan penanganan komplikasi obstetri (Smith et al., 2024). Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada outcome klinis, tetapi juga pada efisiensi sistem pelayanan dan kepuasan pasien. Secara kritis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa telemidwifery memiliki potensi besar sebagai strategi inovatif dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, berbagai studi kasus implementasi telemidwifery menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan akses, kualitas, keselamatan, serta keberlanjutan asuhan kebidanan secara komprehensif. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan tenaga kesehatan, tingkat literasi digital pasien, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan telemidwifery perlu dilakukan melalui pendekatan sistem yang terintegrasi, agar dapat memberikan manfaat optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

F. Tantangan Implementasi

Implementasi digital health dan telemidwifery dalam pelayanan kebidanan menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu dikelola secara sistematis. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan digital (*digital divide*), yaitu ketimpangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan infrastruktur jaringan, akses internet yang tidak stabil, serta keterjangkauan perangkat digital menjadi faktor yang membatasi pemanfaatan layanan berbasis teknologi, khususnya di daerah dengan sumber daya terbatas (World Bank, 2023). Kondisi ini berpotensi memperlebar disparitas pelayanan kesehatan jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan akses.

Selain aspek akses, tingkat literasi digital masyarakat dan tenaga kesehatan juga menjadi determinan penting dalam keberhasilan implementasi telemidwifery. Rendahnya kemampuan dalam menggunakan teknologi digital dapat menghambat pemanfaatan aplikasi kesehatan, menurunkan kualitas interaksi antara bidan dan pasien, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam interpretasi informasi kesehatan (OECD, 2023). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tidak hanya diperlukan bagi pasien, tetapi juga bagi tenaga kesehatan agar mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi secara efektif dan aman dalam praktik klinis.

Di sisi lain, isu keamanan dan privasi data menjadi tantangan krusial dalam pengembangan digital health. Pengelolaan data kesehatan yang bersifat sensitif

memerlukan sistem perlindungan yang kuat untuk mencegah kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta pelanggaran kerahasiaan pasien (World Health Organization [WHO], 2023). Kepercayaan pasien terhadap layanan digital sangat bergantung pada jaminan keamanan data yang diberikan oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, implementasi telemidwifery harus dilengkapi dengan standar keamanan siber, enkripsi data, serta regulasi yang mengatur perlindungan informasi kesehatan secara komprehensif.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek regulasi dan tata kelola sistem kesehatan digital yang belum sepenuhnya matang. Keterbatasan regulasi yang spesifik terkait telemidwifery, termasuk standar praktik, aspek legal, dan tanggung jawab profesional, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan layanan (International Telecommunication Union [ITU], 2023). Selain itu, integrasi antara sistem digital dengan kebijakan kesehatan nasional masih memerlukan penguatan agar implementasi dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

G. Masa Depan *Telemidwifery*

Perkembangan teknologi digital, khususnya artificial intelligence (AI), membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di masa depan. AI memungkinkan analisis data kesehatan secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi risiko kehamilan, seperti preeklamsia, diabetes gestasional, maupun komplikasi obstetri lainnya (OECD, 2023). Kemampuan prediktif ini memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih proaktif, memungkinkan intervensi dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Dengan demikian, telemidwifery berpotensi bertransformasi dari layanan reaktif menjadi sistem pelayanan yang bersifat prediktif dan preventif.

Selain itu, pemanfaatan big data dalam digital health memungkinkan pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan individu pasien. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti aplikasi kesehatan, wearable devices, dan rekam medis elektronik, dapat diolah untuk menghasilkan rekomendasi klinis yang lebih spesifik dan kontekstual (World Health Organization [WHO], 2024). Pendekatan ini mendukung konsep personalized care, di mana intervensi kesehatan disesuaikan dengan karakteristik biologis, perilaku, dan lingkungan pasien. Dalam praktik kebidanan, hal ini berpotensi meningkatkan

efektivitas intervensi serta memperbaiki health outcomes ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, model pelayanan kesehatan masa depan cenderung mengarah pada pendekatan *hybrid care*, yaitu kombinasi antara layanan digital dan layanan tatap muka. Model ini dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif karena mampu mengoptimalkan keunggulan teknologi tanpa mengabaikan pentingnya interaksi langsung dalam praktik klinis (Taylor et al., 2024). Dalam konteks telemidwifery, layanan digital dapat digunakan untuk pemantauan rutin, edukasi, dan konsultasi awal, sementara layanan tatap muka tetap diperlukan untuk pemeriksaan fisik dan tindakan klinis yang lebih kompleks. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan terciptanya pelayanan yang lebih fleksibel, efisien, dan berpusat pada pasien.

Secara keseluruhan, masa depan telemidwifery sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem kesehatan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital secara optimal. Pengembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta regulasi yang adaptif terhadap inovasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, telemidwifery berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi pelayanan kebidanan modern, yang tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas layanan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

H. Sintesis dan Implikasi Praktik

Secara konseptual dan empiris, digital health dan telemidwifery telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses, kualitas, serta health outcomes dalam pelayanan kesehatan maternal (World Health Organization [WHO], 2023). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perluasan jangkauan layanan kebidanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, integrasi teknologi dalam praktik klinis mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan.

Pendekatan ini juga memperkuat implementasi *continuity of care* yang lebih terintegrasi sepanjang siklus kehidupan reproduksi perempuan. Melalui pemanfaatan platform digital, hubungan antara bidan dan pasien dapat terjaga secara berkelanjutan, mulai dari fase prakonsepsi hingga postpartum (Lee et al., 2025). Hal ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara lebih sistematis, deteksi dini risiko, serta pemberian intervensi yang tepat waktu. Dengan demikian, digital health tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memperbaiki kualitas dan kesinambungan asuhan kebidanan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi digital health dan telemidwifery tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sistem kesehatan secara menyeluruh. Integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan kesehatan menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan layanan (World Bank, 2023). Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kompetensi tenaga kesehatan yang adaptif, serta regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi digital berpotensi tidak optimal dan bahkan menimbulkan kesenjangan baru dalam pelayanan kesehatan.

Dari perspektif praktik kebidanan, transformasi digital menuntut adanya peningkatan kompetensi bidan, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga dalam literasi digital dan penggunaan teknologi kesehatan. Bidan dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pemantauan pasien, edukasi kesehatan, serta komunikasi terapeutik berbasis digital. Selain itu, bidan juga harus menjaga prinsip etik dan profesionalisme, terutama dalam hal perlindungan data pasien dan kualitas interaksi dengan pasien dalam lingkungan digital.

Secara keseluruhan, sintesis dari berbagai temuan menunjukkan bahwa digital health dan telemidwifery memiliki potensi besar dalam mentransformasi pelayanan kebidanan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada pasien. Namun, untuk mencapai manfaat yang optimal, diperlukan pendekatan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi dalam kebidanan tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi strategi strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara global.

I. Penutup

Transformasi digital melalui penerapan digital health dan telemidwifery telah membawa perubahan mendasar dalam praktik kebidanan modern. Inovasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pasien (World Health Organization [WHO], 2023). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelayanan kebidanan dilakukan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasien, sehingga memberikan peluang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelayanan maternal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap layanan kesehatan, deteksi dini komplikasi, serta perbaikan

health outcomes ibu dan bayi (Kim et al., 2024). Selain itu, telemidwifery juga memperkuat implementasi continuity of care, yang memastikan bahwa pelayanan kebidanan dapat berlangsung secara berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan reproduksi perempuan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai katalis dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, keberhasilan implementasi digital health dan telemidwifery tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sistem kesehatan secara menyeluruh. Integrasi teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi digital, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (OECD, 2023). Tanpa dukungan tersebut, pemanfaatan teknologi berpotensi tidak optimal dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem yang komprehensif untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, pengembangan digital health dan telemidwifery di masa depan harus diarahkan pada upaya menciptakan pelayanan kebidanan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai humanistik dalam praktik klinis. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi inovasi ini. Dengan pendekatan yang seimbang antara teknologi dan aspek kemanusiaan, digitalisasi dalam kebidanan berpotensi menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak secara global dan berkelanjutan.

Referensi

- Brown, A., Smith, J., & Taylor, K. (2023). *Telemidwifery practice and patient experience: A qualitative analysis. Midwifery, 120, 103600.*
- Garcia, M., Lopez, R., & Chen, H. (2023). *Real-time monitoring systems in maternal health: Clinical implications and outcomes. Journal of Clinical Medicine, 12(18), 5800.*
- International Telecommunication Union. (2023). *Digital health platform handbook.* ITU.
- Johnson, P., Lee, S., & Kim, H. (2024). *Telelactation and maternal support: Impact on breastfeeding outcomes. Frontiers in Public Health, 12, 1189000.*
- Kim, H., Park, J., & Lee, S. (2024). *Mobile health interventions in maternal care: A systematic review and meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 26, e66580.*
- Lee, S., Brown, A., & Taylor, K. (2025). *Digital health interventions and maternal outcomes in antenatal care: A multicenter study. BMC Pregnancy and Childbirth, 25, 102.*
- OECD. (2023). *Health in the digital age: Policy insights for digital transformation.* OECD Publishing.
- Smith, J., Brown, A., & Wilson, M. (2024). *Telemidwifery and telehealth in maternal care: Global perspectives and outcomes. The Lancet Digital Health, 6(2), e100–e110.*
- Taylor, K., Brown, A., & Lee, S. (2024). *Woman-centered care in digital midwifery practice: A conceptual framework. Midwifery, 125, 103750.*
- United Nations Children's Fund. (2023). *Digital health and maternal care: Global guidance.* UNICEF.
- World Bank. (2023). *Digital health for universal health coverage.* World Bank.
- World Health Organization. (2023). *Global digital health monitor: Digital health transformation.* WHO.
- World Health Organization. (2024). *Digital health transformation report.* WHO.

Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi berbasis komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia untuk menganalisis data, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan klinis.

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin selama kehamilan.

Big Data

Kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang berguna dalam pengambilan keputusan kesehatan.

Continuity of Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan pasien, mulai dari pencegahan hingga perawatan lanjutan.

Digital Divide

Kesenjangan akses terhadap teknologi digital antara kelompok masyarakat atau wilayah tertentu, yang berdampak pada ketimpangan pemanfaatan layanan kesehatan.

Digital Health

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akses pelayanan kesehatan.

Early Warning System

Sistem pemantauan yang digunakan untuk mendeteksi secara dini perubahan kondisi pasien yang berpotensi menjadi komplikasi serius.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan.

Evidence-Based Practice

Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.

Health Outcomes

Hasil atau dampak dari pelayanan kesehatan terhadap kondisi kesehatan pasien, baik secara fisik maupun psikologis.

Hybrid Care

Model pelayanan kesehatan yang mengombinasikan layanan digital (online) dan layanan tatap muka (offline).

Literasi Digital

Kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman.

Maternal Health

Kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan postpartum.

Mobile Health (mHealth)

Pemanfaatan perangkat mobile seperti smartphone untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk edukasi dan pemantauan pasien.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan.

Patient Engagement

Keterlibatan aktif pasien dalam proses pengelolaan kesehatannya, termasuk dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap terapi.

Personalized Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik individu pasien.

Postpartum

Periode setelah persalinan yang berlangsung hingga tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil.

Preeklamsia

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan dapat membahayakan ibu serta janin.

Telehealth

Pelayanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi komunikasi untuk konsultasi, diagnosis, dan edukasi.

Telelaktasi

Layanan konseling menyusui yang dilakukan melalui media digital atau komunikasi jarak jauh.

Telemedicine

Penggunaan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh antara tenaga kesehatan dan pasien.

Telemidwifery

Praktik kebidanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan asuhan kepada pasien secara jarak jauh.

Wearable Devices

Perangkat teknologi yang dikenakan pada tubuh untuk memantau kondisi kesehatan secara real-time, seperti detak jantung atau aktivitas fisik.

Woman-Centered Care

Pendekatan pelayanan kebidanan yang berfokus pada kebutuhan, pengalaman, dan preferensi perempuan sebagai pusat pelayanan.

BAB 3

BUKU LITERASI DIGITAL DAN KOMPETENSI BIDAN

A. Pendahuluan

1. Transformasi Digital dalam Pelayanan Kebidanan

Era digital telah merevolusi berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan. Di bidang kebidanan, transformasi digital mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong transisi menuju midwifery models of care yang terintegrasi dengan teknologi digital guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pengurangan kematian ibu (maternal mortality ratio/MMR) (World Health Organization, 2025).

Di Indonesia, transformasi ini menjadi bagian integral dari Transformasi Kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan sejak 2021, dengan pilar Transformasi Teknologi Kesehatan sebagai salah satu fondasi utama. Platform SATUSEHAT (sebelumnya PeduliLindungi) berfungsi sebagai ekosistem pertukaran data kesehatan nasional berbasis FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), memungkinkan integrasi rekam medis elektronik (RME) antar fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk praktik bidan mandiri dan puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

2. Urgensi Literasi Digital dan Kompetensi Bidan di Indonesia

Literasi digital bidan bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat, melainkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara etis dan aman dalam praktik klinis (e-health literacy). International Confederation of Midwives (ICM) dalam Essential Competencies for Midwifery Practice edisi 2024 secara eksplisit memasukkan kompetensi teknologi sebagai bagian integral dari praktik kebidanan, termasuk penggunaan digital tools untuk pengambilan keputusan klinis, komunikasi, dan pemantauan pasien (International Confederation of Midwives, 2024).

Di Indonesia, urgensi ini semakin tinggi seiring peluncuran Kurikulum Kebidanan Nasional baru pada Juni 2025 oleh Kementerian Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), yang menekankan pendidikan berbasis teknologi dan adaptif terhadap perkembangan digital (UNFPA Indonesia, 2025). Namun, studi

menunjukkan bahwa tingkat kematangan TIK di fasilitas kesehatan primer (puskesmas dan bidan mandiri) masih rendah, dengan hanya sebagian kecil yang telah terintegrasi penuh dengan sistem nasional (Aisyah et al., 2024).

Bidan sebagai ujung tombak pelayanan KIA menghadapi tuntutan ganda: kompetensi klinis tradisional dan kompetensi digital baru (penggunaan RME, aplikasi telekonsultasi, pemantauan jarak jauh). Tanpa peningkatan literasi digital yang sistematis, peluang transformasi digital justru berisiko memperlebar kesenjangan pelayanan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

3. Konsep Continuity of Care dalam Konteks Digital

Continuity of Care (CoC) atau kesinambungan pelayanan merupakan model kebidanan yang menyediakan perawatan berkelanjutan oleh bidan yang sama atau tim yang sama sejak kehamilan, persalinan, hingga masa nifas (Susanti et al., 2022). Model ini terbukti meningkatkan kepuasan ibu, mengurangi komplikasi, dan memperkuat hubungan terapeutik.

Dalam konteks digital, CoC berevolusi menjadi Digital Continuity of Care atau Digital CoC, yang mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi mobile, telemedicine, dan platform terintegrasi untuk memastikan kesinambungan tanpa terbatas ruang dan waktu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program CoC berbasis digital di Jawa Barat secara signifikan meningkatkan kepuasan klien nifas (Darmawan, 2025). Model telemidwifery yang dikembangkan di Purwakarta juga menjadi contoh nyata bagaimana chatbot berbasis AI dapat mendukung CoC secara semi-otomatis sambil tetap mempertahankan sentuhan humanis (Stellata et al., 2022).

B. Dasar Teori Dan Konsep Utama

1. Definisi dan Evolusi Literasi Digital di Bidang Kesehatan

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan etis. Menurut UNESCO, literasi digital mencakup kompetensi kognitif, teknis, dan sosial yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat digital (UNESCO, 2018).

Dalam konteks kesehatan, literasi digital berkembang menjadi e-health literacy, yaitu kemampuan individu untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan berbasis elektronik guna pengambilan keputusan yang tepat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Cameron D. Norman dan Harvey A. Skinner yang mendefinisikan e-health literacy sebagai kombinasi dari literasi kesehatan, literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi (Norman & Skinner, 2006).

Seiring perkembangan teknologi, literasi digital kesehatan mengalami evolusi dari sekadar kemampuan membaca informasi online menjadi kemampuan analisis kritis, komunikasi digital, serta perlindungan data pribadi. Organisasi World Health Organization menekankan bahwa literasi digital menjadi komponen penting dalam sistem kesehatan modern, terutama dalam mendukung patient-centered care dan pengambilan keputusan berbasis data (WHO, 2021).

Dalam praktik kebidanan, literasi digital memungkinkan bidan untuk:

- a. Mengakses pedoman klinis berbasis digital
- b. Menggunakan sistem rekam medis elektronik
- c. Berkomunikasi dengan pasien secara virtual
- d. Memberikan edukasi kesehatan berbasis teknologi

Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan tambahan, tetapi merupakan kompetensi inti dalam pelayanan kebidanan modern.

2. Kompetensi Bidan Menurut Standar Nasional dan Internasional (ICM, IBI, Kemenkes)

Kompetensi bidan merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas. Secara global, standar kompetensi bidan ditetapkan oleh International Confederation of Midwives melalui dokumen *Essential Competencies for Midwifery Practice* (ICM, 2019).

ICM mengelompokkan kompetensi bidan ke dalam beberapa domain utama:

- a. Praktik profesional dan etika
- b. Asuhan antenatal
- c. Asuhan persalinan
- d. Asuhan postpartum dan bayi baru lahir

Di Indonesia, standar kompetensi bidan diatur oleh Ikatan Bidan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Regulasi nasional menekankan bahwa bidan harus memiliki kompetensi klinis, komunikasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

Dalam era digital, kompetensi bidan mengalami perluasan yang mencakup:

- a. Penggunaan sistem informasi kesehatan (seperti SATUSEHAT)
- b. Literasi data dan analisis sederhana
- c. Etika penggunaan teknologi
- d. Keamanan dan kerahasiaan data pasien

Menurut WHO (2021), transformasi digital dalam kesehatan menuntut tenaga kesehatan, termasuk bidan, untuk memiliki *digital health competencies* sebagai bagian dari praktik profesional.

3. *Continuity of Care* (CoC) dalam Kebidanan: Model Tradisional vs Digital

Continuity of Care (CoC) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan asuhan dari masa kehamilan, persalinan, hingga postpartum. Konsep ini menjadi inti dalam praktik kebidanan karena berfokus pada hubungan berkelanjutan antara bidan dan pasien.

Menurut WHO (2016), CoC terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Model tradisional CoC biasanya dilakukan melalui:

- a. Kunjungan antenatal rutin
- b. Pendampingan persalinan
- c. Kunjungan nifas secara langsung

Namun, perkembangan teknologi telah melahirkan model *Digital Continuity of Care*, yaitu integrasi teknologi dalam menjaga kesinambungan pelayanan. Model ini meliputi:

- a. Konsultasi jarak jauh (*telehealth*)
- b. Monitoring kehamilan berbasis aplikasi
- c. Komunikasi melalui platform digital

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam CoC dapat meningkatkan akses layanan, terutama di daerah terpencil, serta meningkatkan kepuasan pasien (Greenwood et al., 2022).

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas hubungan interpersonal antara bidan dan pasien dalam konteks digital. Oleh karena itu, pendekatan humanistik tetap harus menjadi dasar dalam implementasi CoC berbasis digital

4. Kerangka Kerja Digital Health Capability untuk Bidan

Kerangka kerja *Digital Health Capability* mengacu pada kemampuan tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam praktik klinis. Framework ini banyak dikembangkan di negara maju seperti Australia dan Eropa.

Menurut Australian Digital Health Agency, kemampuan digital tenaga kesehatan mencakup:

- a. Literasi digital dasar
- b. Penggunaan sistem informasi kesehatan
- c. Analisis data kesehatan

- d. Komunikasi digital dengan pasien
- e. Etika dan keamanan data

Di Eropa, kerangka kerja *European Digital Competence Framework for Health Professionals* menekankan integrasi antara kompetensi digital dan praktik klinis (Car et al., 2019).

Bagi bidan, kerangka ini dapat diadaptasi menjadi beberapa aspek utama:

- a. Penggunaan rekam medis elektronik
- b. Pemanfaatan aplikasi kebidanan
- c. Telekonsultasi dan edukasi digital
- d. Perlindungan data pasien

Implementasi kerangka ini penting untuk memastikan bahwa bidan mampu beradaptasi dengan transformasi digital tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

5. Interkoneksi antara Literasi Digital, Kompetensi Klinis, dan Continuity of Care

Literasi digital, kompetensi klinis, dan *Continuity of Care* merupakan tiga komponen yang saling terhubung dalam pelayanan kebidanan modern. Literasi digital menjadi fondasi yang memungkinkan bidan mengakses dan memanfaatkan teknologi, sementara kompetensi klinis memastikan bahwa pelayanan tetap berbasis evidence.

Menurut WHO (2021), integrasi antara teknologi digital dan kompetensi tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi sistem kesehatan. Dalam konteks ini:

- a. Literasi digital → memungkinkan penggunaan teknologi
- b. Kompetensi klinis → menjamin kualitas asuhan
- c. Continuity of Care → memastikan kesinambungan pelayanan

Ketiga aspek ini membentuk suatu ekosistem pelayanan kebidanan yang holistik dan berpusat pada pasien (*woman-centered care*).

C. Transformasi Pelayanan Kebidanan Di Era Digital

1. Perkembangan Teknologi Digital dalam Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk pada sektor Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi seperti electronic health records (EHR), aplikasi kesehatan mobile (mHealth), telemedicine, serta sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Menurut World Health Organization, pemanfaatan teknologi digital dalam KIA berperan dalam meningkatkan akses layanan, kualitas perawatan, serta pengambilan keputusan berbasis data (WHO, 2020). Di Indonesia, digitalisasi

layanan kesehatan didukung melalui platform seperti SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2022).

Teknologi mHealth memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh informasi kesehatan secara real-time melalui aplikasi mobile. Studi oleh World Bank menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kunjungan antenatal serta pemantauan kehamilan (World Bank, 2021).

Selain itu, penggunaan perangkat wearable dan Internet of Things (IoT) dalam pemantauan kesehatan ibu juga mulai berkembang. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini risiko kehamilan melalui pemantauan parameter fisiologis secara kontinu (Lupton, 2019).

2. Model Pelayanan Kebidanan Berbasis Digital

Model pelayanan kebidanan berbasis digital merupakan inovasi dalam pemberian asuhan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan. Model ini mencakup berbagai pendekatan, antara lain:

a. Telemedicine dalam Kebidanan

Telemedicine memungkinkan bidan memberikan konsultasi, edukasi, dan tindak lanjut secara jarak jauh. Menurut World Health Organization, telemedicine efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil (WHO, 2019).

b. Aplikasi Mobile Kesehatan (mHealth)

Aplikasi kesehatan memberikan informasi terkait kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Penelitian oleh Lee et al. (2018) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mHealth dapat meningkatkan pengetahuan ibu dan kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan.

c. Sistem Rekam Medis Elektronik (RME)

RME memungkinkan pencatatan data pasien secara digital dan terintegrasi. Hal ini meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kontinuitas pelayanan (Adler-Milstein & Jha, 2017).

d. Platform Terintegrasi

Platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan memungkinkan koordinasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih efektif. Contohnya adalah integrasi data antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan.

Dalam implementasinya, model pelayanan ini harus tetap memperhatikan aspek etika, keamanan data, serta kualitas interaksi antara bidan dan pasien.

3. Integrasi Continuity of Care dengan Teknologi Digital (Digital CoC)

Integrasi *Continuity of Care* (CoC) dengan teknologi digital menghasilkan konsep *Digital Continuity of Care*, yaitu pendekatan pelayanan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi digital. Menurut World Health Organization, kesinambungan pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan outcome kesehatan ibu dan bayi (WHO, 2016). Dengan dukungan teknologi digital, CoC dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Model *Digital CoC* meliputi:

- a. Pemantauan kehamilan berbasis aplikasi
- b. Konsultasi daring secara berkala
- c. Pengingat jadwal kunjungan dan imunisasi
- d. Follow-up postpartum secara digital

Penelitian oleh Kruse et al. (2020) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepuasan pasien serta efisiensi pelayanan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi *Digital CoC* sangat bergantung pada:

- a. Tingkat literasi digital bidan dan pasien
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi
- c. Dukungan kebijakan pemerintah

D. Literasi Digital Bidan: Komponen Dan Dimensi

1. Dimensi Literasi Digital

Literasi digital merupakan kompetensi multidimensional yang mencakup kemampuan teknis, kognitif, dan sosial dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Dalam konteks kesehatan, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi kesehatan secara kritis.

Menurut UNESCO, literasi digital mencakup beberapa dimensi utama, yaitu keterampilan informasi, komunikasi, pembuatan konten, keamanan digital, dan pemecahan masalah (UNESCO, 2018). Dimensi ini menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk bidan.

Dalam konteks kebidanan, dimensi literasi digital dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Literasi Informasi: kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi kesehatan yang valid.
 - b. Komunikasi Digital: kemampuan berinteraksi dengan pasien melalui media digital secara efektif dan empatik.
 - c. Pembuatan Konten Digital: kemampuan menyusun materi edukasi kesehatan berbasis digital.
 - d. Keamanan Digital: kemampuan melindungi data pasien dan menjaga privasi.
 - e. Problem-Solving Digital: kemampuan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah klinis.
2. Literasi Digital Kesehatan (e-Health Literacy)

Literasi digital kesehatan atau e-health literacy merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan berbasis digital untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Konsep ini mengintegrasikan berbagai jenis literasi, termasuk literasi informasi, media, komputer, dan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa e-health literacy memiliki enam komponen utama, yaitu literasi tradisional, literasi informasi, literasi media, literasi komputer, literasi sains, dan literasi kesehatan (Norman & Skinner dalam Zahra & Solihin, 2025) .

Dalam praktik kebidanan, e-health literacy berperan penting dalam:

- a. Mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis informasi
- b. Meningkatkan kualitas edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga
- c. Mengurangi risiko penyebaran informasi kesehatan yang salah (misinformation)

Penelitian menunjukkan bahwa literasi kesehatan digital berpengaruh signifikan terhadap perilaku kesehatan, termasuk kepatuhan terhadap praktik pencegahan penyakit dan penggunaan layanan kesehatan (Syafei, 2023). Selain itu, kemampuan literasi digital kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menghadapi fenomena infodemic, yaitu penyebaran informasi berlebihan yang belum tentu valid, terutama pada masa krisis kesehatan seperti pandemi (Oktaviana, 2025)

3. Penilaian Tingkat Literasi Digital Bidan di Indonesia

Penilaian tingkat literasi digital bidan menjadi langkah penting dalam mengetahui kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi transformasi digital. Berbagai instrumen telah dikembangkan untuk mengukur literasi digital kesehatan, salah satunya adalah Digital Health Literacy Competencies (DHLC).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi digital tenaga kesehatan masih bervariasi. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta akses terhadap teknologi (Rachmani et al., 2023) .

Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa literasi digital juga memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi kesehatan. Rendahnya literasi digital dapat menjadi hambatan dalam pengisian data dan pemanfaatan sistem informasi secara optimal (Setiawan, 2023) .

Di Indonesia, sebagian besar tenaga kesehatan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi, namun masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan evaluasi kritis terhadap informasi digital (Fauziah & Solihin, 2025) . Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam:

- a. Melakukan asesmen literasi digital secara berkala
- b. Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi digital
- c. Meningkatkan akses terhadap teknologi kesehatan

4. Perbedaan Literasi Digital antar Generasi Bidan

Perbedaan generasi menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat literasi digital. Secara umum, terdapat dua kelompok utama, yaitu:

Digital Native: generasi yang sejak lahir telah terpapar teknologi digital

Digital Immigrant: generasi yang harus beradaptasi dengan teknologi di usia dewasa

Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memiliki kemampuan teknis yang lebih baik dalam menggunakan teknologi digital. Namun, kemampuan tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi (Fauziah & Solihin, 2025) .

Sebaliknya, generasi yang lebih senior mungkin memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, tetapi memiliki pengalaman klinis yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, faktor usia, pendidikan, dan pengalaman juga berpengaruh terhadap tingkat literasi digital kesehatan. Studi menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan dengan kemampuan literasi digital, di mana kelompok usia lebih muda cenderung memiliki skor lebih tinggi (Syafei, 2023) .

Perbedaan ini menuntut pendekatan yang berbeda dalam pengembangan kompetensi, antara lain:

- a. Pelatihan teknologi untuk generasi senior
- b. Penguatan kemampuan berpikir kritis untuk generasi muda
- c. Kolaborasi lintas generasi dalam praktik kebidanan

E. Pengembangan Kompetensi Bidan Di Era Digital

Transformasi digital dalam sektor kesehatan telah mendorong perubahan signifikan dalam tuntutan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk bidan. Di era digital, bidan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis yang kuat, tetapi juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Pengembangan kompetensi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan tetap berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan pasien di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

Kompetensi teknis merupakan aspek fundamental dalam pengembangan kapasitas bidan di era digital. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam menggunakan berbagai teknologi kesehatan, seperti sistem rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan ibu dan anak, serta platform telemedicine. Penguasaan teknologi ini memungkinkan bidan untuk melakukan pencatatan data pasien secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mempermudah koordinasi antar tenaga kesehatan. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi dalam praktik kebidanan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengurangi beban administratif tenaga kesehatan (Wulandari & Mokodompit, 2025). Selain itu, pelatihan berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengoperasikan aplikasi digital secara optimal dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Trisnadoli et al., 2025). Dengan demikian, kompetensi teknis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencerminkan kesiapan bidan dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan yang semakin terdigitalisasi.

Di samping kompetensi teknis, kompetensi non-teknis juga memiliki peran yang sangat penting dalam praktik kebidanan di era digital. Kompetensi ini mencakup aspek etika digital, komunikasi virtual, serta perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien. Dalam konteks pelayanan digital, bidan harus mampu menjaga profesionalisme dalam interaksi berbasis teknologi serta memastikan bahwa informasi pasien terlindungi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap etika digital dan regulasi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pasien (Jurnal Kesehatan Vokasional, 2025). Selain itu, kemampuan komunikasi yang efektif melalui media digital menjadi tantangan tersendiri, karena bidan tetap dituntut untuk membangun hubungan empatik meskipun tidak berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, kompetensi non-teknis menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kebidanan agar tetap humanis di tengah penggunaan teknologi.

Upaya peningkatan kompetensi bidan di era digital memerlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pelatihan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi pembelajaran daring, seperti webinar, e-learning, dan workshop interaktif. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital dapat meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan (Winarti et al., 2024). Selain itu, program pendampingan atau mentoring juga dapat membantu bidan dalam mengaplikasikan keterampilan digital dalam praktik sehari-hari. Pengembangan kurikulum kebidanan yang terintegrasi dengan keterampilan digital juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang kompeten di masa depan. Kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi ini.

Perkembangan teknologi seperti simulasi, Virtual Reality (VR), dan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kebidanan. Metode simulasi memungkinkan bidan untuk berlatih keterampilan klinis dalam lingkungan yang aman dan terkendali, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam menghadapi situasi nyata. Penggunaan VR menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif, di mana bidan dapat memahami kondisi klinis secara lebih realistis melalui visualisasi tiga dimensi. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi VR efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis tenaga kesehatan (Zulkifli & Ardianto, 2024). Selain itu, penggunaan simulasi pasien virtual juga dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan (Liananiar et al., 2024).

Sementara itu, Artificial Intelligence (AI) memiliki potensi besar dalam mendukung pelayanan dan pendidikan kebidanan. AI dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan, memprediksi risiko kehamilan, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan klinis. Pemanfaatan AI dalam edukasi kesehatan juga terbukti mampu meningkatkan pengetahuan ibu hamil secara signifikan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan (Faujiah, 2025). Selain itu, pelatihan berbasis AI dapat membantu meningkatkan literasi digital tenaga kesehatan serta kesiapan dalam menghadapi transformasi digital (Siswati et al., 2025). Meskipun demikian, penggunaan teknologi ini tetap harus disertai dengan pertimbangan etika dan pengawasan profesional agar tidak mengurangi peran manusia dalam pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi bidan di era digital merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang mencakup integrasi antara kompetensi teknis dan non-teknis. Dukungan strategi pendidikan yang inovatif serta pemanfaatan teknologi canggih menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Dengan demikian, bidan diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai humanistik dalam pelayanan, sehingga tetap mampu memberikan asuhan yang berpusat pada kebutuhan perempuan (woman-centered care).

F. Tantangan Dan Hambatan

Transformasi digital dalam pelayanan kebidanan membawa berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Meskipun teknologi digital mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Tantangan ini perlu dipahami secara komprehensif agar pengembangan sistem pelayanan kebidanan berbasis digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi pelayanan kebidanan digital adalah keterbatasan infrastruktur dan akses internet, khususnya di wilayah terpencil dan daerah dengan sumber daya terbatas. Ketimpangan akses teknologi ini menyebabkan layanan kesehatan digital belum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Studi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan infrastruktur digital dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi digitalisasi layanan kesehatan, terutama di negara berkembang (Manurung & Simarmata, 2025). Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan kebidanan, di mana bidan di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem informasi kesehatan, melakukan konsultasi jarak jauh, maupun memanfaatkan aplikasi digital untuk pemantauan pasien. Akibatnya, kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu yang signifikan.

Selain hambatan infrastruktur, isu etika, privasi, dan keamanan data juga menjadi tantangan besar dalam digitalisasi pelayanan kebidanan. Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan melibatkan pengumpulan dan pengelolaan data pasien dalam jumlah besar, yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Penelitian menunjukkan bahwa sistem kesehatan digital masih rentan terhadap ancaman siber dan pelanggaran privasi akibat lemahnya sistem keamanan dan kurangnya regulasi yang terintegrasi (Sintyasari & Risdawati, 2025). Selain itu, perkembangan teknologi seperti Artificial

Intelligence dan Internet of Things juga meningkatkan kompleksitas dalam perlindungan data kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga keamanan informasi pasien (Bahrudin & Arif, 2024) . Dalam praktik kebidanan, menjaga kerahasiaan data pasien merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar, sehingga bidan harus memiliki pemahaman yang kuat terkait regulasi dan etika penggunaan teknologi digital. Penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi digital dan pemahaman terhadap regulasi perlindungan data berpengaruh signifikan terhadap kesiapan bidan dalam menjaga kerahasiaan pasien (Jurnal Kesehatan Vokasional, 2025) .

Tantangan lainnya berkaitan dengan resistensi budaya dan adaptasi terhadap teknologi di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat. Perubahan dari sistem pelayanan konvensional ke sistem digital seringkali menghadapi penolakan atau keraguan, terutama dari tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan teknologi. Resistensi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan, keterbatasan literasi digital, serta kekhawatiran terhadap perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya percaya terhadap layanan kesehatan berbasis digital, terutama terkait keamanan data dan kualitas pelayanan. Studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam adopsi teknologi kesehatan secara luas (Manurung & Simarmata, 2025) . Oleh karena itu, proses adaptasi teknologi tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur, tetapi juga perubahan budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dalam konteks Continuity of Care (CoC), integrasi teknologi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun teknologi memungkinkan pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui platform digital, terdapat kekhawatiran bahwa hubungan interpersonal antara bidan dan pasien dapat berkurang. Pelayanan kebidanan pada dasarnya bersifat humanistik dan berpusat pada hubungan emosional yang kuat antara bidan dan ibu. Digitalisasi berpotensi mengurangi kualitas interaksi tersebut jika tidak diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam CoC juga bergantung pada kesiapan pasien dalam mengakses dan memahami layanan digital, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam pelayanan kesehatan. Literatur menunjukkan bahwa implementasi layanan kesehatan digital harus tetap memperhatikan aspek humanistik agar tidak mengurangi kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien (Sintyasari & Risdawati, 2025)

G. Strategi Dan Inovasi

Penguatan literasi digital dan kompetensi bidan di era transformasi kesehatan memerlukan strategi yang adaptif dan inovatif. Salah satu pendekatan utama adalah pengembangan model pelatihan literasi digital yang berbasis kebutuhan praktik. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring, sehingga memungkinkan bidan untuk meningkatkan keterampilan digital secara fleksibel dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis digital efektif dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kesehatan (Putri et al., 2023).

Selain pelatihan, pengembangan kurikulum kebidanan juga perlu disesuaikan dengan tuntutan era digital. Integrasi kompetensi digital ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi sistem pelayanan kesehatan modern. Kurikulum yang adaptif tidak hanya menekankan keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan literasi digital, analisis data, serta etika penggunaan teknologi. Studi menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan kesehatan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi transformasi digital (Frenk et al., 2022).

Kolaborasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi strategi ini. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan sektor swasta diperlukan untuk mendukung pengembangan kompetensi bidan secara komprehensif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transformasi digital kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2022). Melalui kolaborasi ini, program pelatihan, pengembangan kebijakan, serta penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemanfaatan media sosial secara bijak juga menjadi bagian dari strategi inovatif dalam pelayanan kebidanan. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi kesehatan, komunikasi dengan pasien, serta penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan aspek etika, profesionalisme, dan validitas informasi. Studi menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat apabila digunakan secara tepat (Moorhead et al., 2019).

Secara keseluruhan, strategi dan inovasi dalam pengembangan kompetensi bidan di era digital harus dilakukan secara terpadu melalui pelatihan yang berkelanjutan, kurikulum yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan

teknologi secara bijak. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan sekaligus memperkuat peran bidan dalam sistem kesehatan digital.

H. Simpulan

Transformasi digital dalam pelayanan kebidanan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan sistem kesehatan modern. Integrasi teknologi digital dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya bidan, dalam menguasai literasi digital dan mengembangkan kompetensi yang relevan.

Literasi digital menjadi fondasi utama dalam mendukung praktik kebidanan di era digital, karena memungkinkan bidan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi kesehatan secara efektif. Literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi digital, serta kesadaran terhadap keamanan dan etika penggunaan teknologi. Dalam konteks ini, e-health literacy menjadi bagian penting yang memperkuat kemampuan bidan dalam memberikan edukasi dan pengambilan keputusan berbasis informasi digital.

Pengembangan kompetensi bidan di era digital harus mencakup keseimbangan antara kompetensi teknis dan non-teknis. Kompetensi teknis berkaitan dengan penguasaan teknologi kesehatan seperti rekam medis elektronik dan telemedicine, sedangkan kompetensi non-teknis meliputi aspek etika, komunikasi, dan perlindungan data pasien. Integrasi kedua aspek ini menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan kebidanan yang tetap humanis dan berpusat pada kebutuhan perempuan (woman-centered care).

Konsep Continuity of Care (CoC) sebagai inti pelayanan kebidanan juga mengalami transformasi melalui integrasi teknologi digital. Digital Continuity of Care memungkinkan pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui platform digital, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan interpersonal antara bidan dan pasien. Oleh karena itu, pendekatan humanistik tetap harus menjadi landasan dalam implementasi teknologi.

Berbagai tantangan dan hambatan masih menjadi kendala dalam implementasi transformasi digital, seperti keterbatasan infrastruktur, isu etika dan keamanan data, serta resistensi terhadap perubahan. Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi dan inovasi yang terintegrasi, meliputi pengembangan pelatihan literasi digital, penyesuaian kurikulum kebidanan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan media sosial secara bijak. Selain itu, pemanfaatan teknologi inovatif seperti simulasi, Virtual Reality, dan Artificial Intelligence juga dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kompetensi bidan.

Dengan demikian, bidan di era digital diharapkan mampu menjadi tenaga kesehatan yang adaptif, kompeten, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai humanistik dalam pelayanan. Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan ibu dan anak secara berkelanjutan.

Referensi

- Adler-Milstein, J., & Jha, A. K. (2017). HITECH Act drove large gains in hospital electronic health record adoption. *Health Affairs*, 36(8), 1416–1422. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.1651>
- Aisyah, D. N., et al. (2024). The information and communication technology maturity of Indonesian health care services. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e55959. <https://doi.org/10.2196/55959>
- Bahrudin, & Arif, T. (2024). Keamanan inovasi kesehatan digital sebagai perwujudan artificial intelligence (AI) dalam penyebaran informasi kesehatan. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*.
- Car, J., Carlstedt-Duke, J., Tudor Car, L., Posadzki, P., Whiting, P., Zary, N., ... Atun, R. (2019). Digital health education: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 21(2), e12931. <https://doi.org/10.2196/12931>
- Darmawan, F. H. (2025). Effectiveness of digital-based continuity of midwifery care on client satisfaction in West Java, Indonesia. *The Malaysian Journal of Nursing*, 16(1).
- Delmaifanis, Antarsih, N. R., & Siregar, K. N. (2025). Digital transformation in antenatal care in Indonesia: The effectiveness of the 'Bundaqusehat' application. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 13(2), 230–238. <https://doi.org/10.20473/jpk.V13.I2.2025.230-238>
- Faujiah, I. N. (2025). Pemberdayaan ibu hamil melalui kelas ibu "HAMIL-AI". *Jurnal Abdimas Kesehatan*.
- Fauziah, A. P., & Solihin, O. (2025). *Literasi kesehatan digital*.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., ... Zurayk, H. (2022). Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems. *The Lancet*.
- Greenwood, D. A., Gee, P. M., Fatkin, K. J., & Peeples, M. (2022). A systematic review of reviews evaluating technology-enabled diabetes self-management education. *Telemedicine and e-Health*, 28(3), 310–320.
- International Confederation of Midwives. (2019). *Essential competencies for midwifery practice*.
- International Confederation of Midwives. (2024). ICM essential competencies for midwifery practice. The Hague: International Confederation of Midwives. <https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice/>
- Jurnal Kesehatan Vokasional. (2025). Kompetensi digital dan etika kerahasiaan tenaga kesehatan.

- Jurnal Kesehatan Vokasional. (2025). Kompetensi digital dan etika kerahasiaan tenaga kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi digital kesehatan melalui platform SATUSEHAT*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Blueprint for digital health transformation strategy 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kruse, C. S., Krowski, N., Rodriguez, B., Tran, L., Vela, J., & Brooks, M. (2020). Telehealth and patient satisfaction: A systematic review. *BMJ Open*, 10(8), e036277.
- Lee, S. H., Nurmatov, U. B., Nwaru, B. I., Grant, L., Pagliari, C., & Bonell, C. (2018). Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health. *BMC Public Health*, 18(1), 1–14.
- Liananar, Y., Rahmah, S., & Yuswita. (2024). Penerapan virtual patient simulations dalam pembelajaran kebidanan. *Jurnal Kebidanan*.
- Lupton, D. (2019). *The quantified self: A sociology of self-tracking*. Polity Press.
- Manurung, P. I. R., & Simarmata, M. (2025). Digitalisasi layanan kesehatan: Tantangan etika dan keamanan data pasien. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 263–273. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.811>
- McGonigle, D., & Mastrian, K. (2021). *Nursing informatics and the foundation of knowledge* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2019). A new dimension of health care: Systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. *Journal of Medical Internet Research*, 21(4), e12851.
- Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). eHealth literacy: Essential skills for consumer health in a networked world. *Journal of Medical Internet Research*, 8(2), e9. <https://doi.org/10.2196/jmir.8.2.e9>
- Oktaviana, N. H. (2025). Peran literasi kesehatan digital dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat.
- Putri, A. R., Nugroho, R., & Hidayat, T. (2023). Efektivitas pelatihan literasi digital bagi tenaga kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

- Rachmani, E., Dewi, F., Haikal, H., & Setiono, O. (2023). Pengukuran literasi kesehatan digital kader kesehatan menggunakan SI-Cerdik. *Indonesian Journal of Health Information Management Services*, 3(1), 7–10. <https://doi.org/10.33560/ijhims.v3i1.57>
- Setiawan, M. Y. (2023). Tingkat literasi digital dan penerimaan sistem informasi pada petugas kesehatan. *Journal of Information Systems for Public Health*, 8(2).
- Sintyasari, D., & Risdawati, I. (2025). Urgensi reformasi hukum kesehatan di era digital: Antara etika, privasi data, dan perlindungan hak pasien. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.5878>
- Siswati, S., Syafrawati, & Amelia, S. (2025). Workshop artificial intelligence dalam transformasi kesehatan digital. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*.
- Smith, V., Daly, D., Lundgren, I., Eri, T., Benstoem, C., & Devane, D. (2022). Telehealth for maternity care during COVID-19. *Midwifery*, 102, 103–110.
- Stellata, A. G., et al. (2022). Exploration of telemidwifery: An initiation of application menu content for village midwives and pregnant women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10713. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710713>
- Susanti, A. I., et al. (2022). Midwifery continuity of care in Indonesia: Initiation of mobile health development integrating midwives' competency and service needs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 13893. <https://doi.org/10.3390/ijerph192113893>
- Syafei, A. (2023). Literasi kesehatan digital dan hubungannya dengan perilaku kesehatan: Scoping review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Trisnadoli, A., Lestari, I., Savitri, A. I., & Utari, M. D. (2025). Pemanfaatan teknologi kesehatan digital untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu. *Jurnal Inovasi Terapan*.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills*.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills*.
- UNFPA Indonesia. (2025, 19 Juni). Indonesia launches new national midwifery curriculum. <https://indonesia.unfpa.org/en/news/indonesia-launches-new-national-midwifery-curriculum>
- Winarti, E., Mirasa, Y. A., Alimansur, M., & Setiani, E. M. (2024). Pelatihan literasi digital sebagai upaya peningkatan pemahaman kesehatan. *Jurnal Salam Sehat Masyarakat*.
- World Bank. (2021). *Digital health and the future of healthcare*.
- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*.

- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care*.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*.
- World Health Organization. (2020). *Digital health: Transforming and extending care*.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*.
- World Health Organization. (2025). Implementation guidance on transitioning to midwifery models of care. Geneva: World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/381641>.
- Wulandari, B. A., & Mokodompit, E. A. (2025). Digitalisasi strategi SDM untuk praktik bidan ideal. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Zahra, H. A., & Solihin, O. (2025). Literasi kesehatan digital era infodemic: Analisis konseptual.
- Zulkifli, & Ardianto, R. (2024). Tren dan tantangan penerapan virtual reality di bidang kesehatan. *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*.

Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer melakukan analisis data, prediksi, dan pengambilan keputusan secara otomatis.

Continuity of Care (CoC)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan asuhan dari masa kehamilan, persalinan, hingga postpartum.

Digital Continuity of Care (Digital CoC)

Pengembangan konsep CoC yang memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan secara jarak jauh maupun terintegrasi.

Digital Health

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan kesehatan, termasuk telemedicine, aplikasi kesehatan, dan sistem informasi kesehatan.

e-Health Literacy

Kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan berbasis digital untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Literasi Digital

Kemampuan dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab.

mHealth (Mobile Health)

Pemanfaatan perangkat mobile seperti smartphone untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk edukasi dan pemantauan pasien.

Rekam Medis Elektronik (RME)

Sistem pencatatan data pasien secara digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan.

Telemedicine

Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital.

Virtual Reality (VR)

Teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi virtual yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara imersif.

Woman Centered Care

Pendekatan pelayanan kebidanan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan pengalaman perempuan sebagai pusat pelayanan.

BAB 4

MODEL PELAYANAN KEBIDANAN MASA DEPAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara komprehensif mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Dalam beberapa dekade terakhir, pelayanan kebidanan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, transformasi sistem kesehatan, serta tuntutan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Perubahan global yang ditandai dengan berkembangnya era digital telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor kesehatan. Transformasi digital kesehatan mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi digital (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2023). Dalam konteks kebidanan, perkembangan teknologi menghadirkan berbagai inovasi seperti telemedicine, telemidwifery, aplikasi kesehatan ibu dan anak, rekam medis elektronik, artificial intelligence (AI), wearable devices, hingga sistem monitoring kesehatan berbasis internet.

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi serta kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (UNICEF, 2021; Kemenkes RI, 2023). Tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), ketimpangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta masalah geografis menjadi tantangan utama yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan pola penyakit, meningkatnya risiko kehamilan komplikasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses menjadi faktor yang mempercepat kebutuhan transformasi pelayanan kebidanan.

Pemerintah Indonesia melalui transformasi sistem kesehatan nasional terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian utama adalah continuity of care (CoC) atau pelayanan berkesinambungan. Pendekatan ini menekankan pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan sejak masa prakonsepsi hingga masa nifas dan keluarga berencana. Model pelayanan ini diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, menurunkan komplikasi, dan memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dan pasien.

Di era Society 5.0, pelayanan kebidanan tidak hanya dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus tetap mempertahankan nilai humanistik, empati, dan woman centered care. Bidan masa depan diharapkan memiliki kompetensi multidimensional yang tidak hanya berfokus pada keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan digital, komunikasi virtual, kolaborasi interprofesional, critical thinking, serta kemampuan pengambilan keputusan berbasis *evidence based practice*.

Model pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia diprediksi akan mengarah pada integrasi antara pelayanan berbasis teknologi digital dengan pendekatan continuity of care yang holistik dan berpusat pada perempuan. Pelayanan kebidanan akan semakin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan tanpa menghilangkan aspek kemanusiaan dalam praktik kebidanan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai model pelayanan kebidanan masa depan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, maupun pemangku kebijakan kesehatan. Bab ini akan membahas transformasi pelayanan kebidanan di era digital, konsep continuity of care, model pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia, kompetensi bidan masa depan, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kebidanan berbasis teknologi dan pelayanan berkelanjutan.

B. Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital

1. Konsep Transformasi Digital dalam Kebidanan

Transformasi digital merupakan proses perubahan sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan. Dalam bidang kesehatan, transformasi digital dikenal sebagai digital health atau e-health yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan (OECD, 2020; WHO, 2021).

Transformasi digital dalam kebidanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal melalui pemanfaatan teknologi digital. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat elektronik, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, sistem pelayanan, pola komunikasi, dan pengambilan keputusan klinis.

Pelayanan kebidanan modern mulai mengintegrasikan berbagai teknologi seperti rekam medis elektronik (electronic medical record), telemedicine, telemidwifery, aplikasi mobile kesehatan ibu, konsultasi online, wearable devices, hingga sistem pengingat digital untuk ibu hamil. Teknologi tersebut membantu bidan dalam melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Perkembangan transformasi digital juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi kesehatan melalui media digital. Kondisi ini menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Pasien tidak lagi hanya bergantung pada pelayanan tatap muka, tetapi mulai memanfaatkan layanan kesehatan berbasis digital.

Dalam praktik kebidanan, transformasi digital memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, mempercepat sistem rujukan, mempermudah dokumentasi pelayanan, meningkatkan efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data.

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital tenaga kesehatan dan masyarakat, keamanan data pasien, serta perlunya regulasi yang jelas terkait pelayanan kesehatan digital.

2. Perkembangan Teknologi dalam Pelayanan Kebidanan

Perkembangan teknologi kesehatan memberikan dampak besar terhadap perubahan pelayanan kebidanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Inovasi teknologi terus berkembang untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih efektif, aman, dan terjangkau.

Salah satu perkembangan penting adalah penggunaan aplikasi kesehatan ibu dan anak berbasis smartphone. Aplikasi ini memungkinkan ibu hamil memperoleh edukasi kesehatan, memantau perkembangan kehamilan, mencatat jadwal pemeriksaan, hingga melakukan konsultasi secara online dengan tenaga kesehatan.

Telemidwifery atau pelayanan kebidanan jarak jauh menjadi salah satu inovasi yang berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 dan terbukti

membantu meningkatkan akses pelayanan maternal di berbagai negara (Feroz et al., 2021). Pelayanan ini memungkinkan bidan memberikan konsultasi, edukasi, pemantauan kesehatan, dan pendampingan kepada ibu hamil tanpa harus melakukan kontak langsung. Model pelayanan ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan akses tenaga kesehatan.

Penggunaan wearable devices juga mulai diterapkan dalam pelayanan maternal. Perangkat ini dapat memantau tekanan darah, denyut jantung, kadar oksigen, aktivitas fisik, hingga kontraksi uterus secara real time. Data yang diperoleh dapat dikirim secara otomatis kepada tenaga kesehatan untuk dilakukan monitoring dan deteksi dini komplikasi.

Selain itu, artificial intelligence (AI) mulai digunakan dalam pelayanan kesehatan maternal untuk membantu deteksi risiko kehamilan, analisis data kesehatan, dan sistem pengambilan keputusan klinis. AI dapat membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi risiko komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan persalinan prematur berdasarkan data klinis pasien.

Pemerintah Indonesia juga mulai mengembangkan integrasi sistem informasi kesehatan melalui platform SATUSEHAT. Sistem ini bertujuan mengintegrasikan data kesehatan masyarakat secara nasional sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih terkoordinasi dan efektif.

Perkembangan teknologi lainnya meliputi penggunaan virtual antenatal class, chatbot edukasi kesehatan ibu, sistem rujukan elektronik, serta penggunaan big data dalam pemetaan masalah kesehatan maternal dan neonatal.

C. Continuity of Care sebagai Dasar Pelayanan Kebidanan Masa Depan

1. Konsep Continuity of Care

Continuity of care (CoC) merupakan model pelayanan kesehatan yang memberikan asuhan secara berkesinambungan dan terintegrasi kepada pasien dalam seluruh tahap kehidupan atau kondisi kesehatannya (WHO, 2021). Dalam pelayanan kebidanan, continuity of care berarti pelayanan yang diberikan secara terus menerus mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana.

Konsep continuity of care berfokus pada woman centered care yaitu pelayanan yang berpusat pada kebutuhan perempuan secara holistik (ICM, 2021). Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya.

Continuity of care memiliki beberapa prinsip utama yaitu pelayanan berkelanjutan, hubungan terapeutik antara bidan dan pasien, koordinasi pelayanan, komunikasi efektif, serta pelayanan yang holistik dan individual.

Model pelayanan continuity of care memberikan berbagai manfaat bagi ibu dan bayi. Penelitian menunjukkan bahwa continuity of care dapat meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan kesehatan, menurunkan intervensi medis yang tidak diperlukan, meningkatkan keberhasilan menyusui, serta menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal.

Selain itu, continuity of care juga memperkuat hubungan emosional antara bidan dan pasien sehingga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Hubungan yang baik antara bidan dan pasien menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan kebidanan.

2. Implementasi Continuity of Care di Indonesia

Implementasi continuity of care di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Distribusi tenaga bidan yang belum merata menyebabkan pelayanan berkesinambungan sulit diterapkan secara optimal.

Selain itu, sistem rujukan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam continuity of care. Banyak pasien yang mengalami keterlambatan rujukan akibat keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi, dan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan continuity of care melalui penguatan pelayanan primer dan pemanfaatan teknologi digital. Posyandu, puskesmas, praktik mandiri bidan, dan pelayanan berbasis komunitas dapat menjadi fondasi pengembangan continuity of care.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendukung continuity of care melalui monitoring kesehatan jarak jauh, konsultasi online, pengingat jadwal pemeriksaan, dan sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Dalam konteks budaya Indonesia, continuity of care juga dapat dikembangkan melalui pendekatan keluarga dan komunitas. Keterlibatan keluarga dalam pelayanan kesehatan ibu menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pelayanan kebidanan.

D. Model Pelayanan Kebidanan Masa Depan di Indonesia

1. Model Pelayanan Kebidanan Berbasis Digital

Pelayanan kebidanan berbasis digital diprediksi menjadi salah satu model pelayanan utama di masa depan. Model ini memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh proses pelayanan kebidanan mulai dari pendaftaran pasien,

pemeriksaan kesehatan, konsultasi, dokumentasi, monitoring, hingga evaluasi pelayanan.

Telemidwifery menjadi salah satu bentuk pelayanan kebidanan digital yang memiliki potensi besar di Indonesia. Melalui telemidwifery, bidan dapat memberikan pelayanan konsultasi, edukasi, monitoring, dan pendampingan kepada ibu hamil tanpa dibatasi oleh jarak geografis.

Model pelayanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil, wilayah kepulauan, maupun daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Selain meningkatkan akses pelayanan kesehatan, telemidwifery juga membantu mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu pasien.

Rekam medis elektronik juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan masa depan. Sistem ini mempermudah dokumentasi pelayanan, meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data.

Artificial intelligence diprediksi akan semakin banyak digunakan dalam pelayanan maternal untuk membantu deteksi dini komplikasi dan pengambilan keputusan klinis berbasis data (Topol, 2020). Sistem AI dapat membantu bidan dalam melakukan skrining risiko kehamilan, memprediksi komplikasi, serta memberikan rekomendasi klinis berdasarkan data pasien.

Selain itu, penggunaan aplikasi mobile kesehatan ibu akan semakin berkembang. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan kehamilan, memberikan edukasi kesehatan, mengingatkan jadwal pemeriksaan, serta mendukung komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan.

2. Model Pelayanan Berbasis Komunitas dan Keluarga

Pelayanan kebidanan masa depan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga tetap memperhatikan pendekatan komunitas dan keluarga. Indonesia sebagai negara dengan budaya kolektif memiliki potensi besar dalam pengembangan pelayanan kesehatan berbasis keluarga dan komunitas.

Model pelayanan berbasis komunitas menekankan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan maternal di negara berkembang (UNICEF, 2021). Bidan berperan sebagai educator, fasilitator, konselor, dan motivator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

Kader kesehatan, posyandu, tokoh masyarakat, dan keluarga dapat dilibatkan secara aktif dalam mendukung pelayanan kebidanan. Pendekatan ini membantu meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan, kepatuhan pemeriksaan antenatal, serta keberhasilan program kesehatan ibu dan anak.

Pelayanan berbasis keluarga juga penting dalam continuity of care. Keluarga memiliki peran besar dalam mendukung kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Oleh karena itu, edukasi kesehatan keluarga menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan masa depan.

3. Model Collaborative Practice

Model collaborative practice merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui kolaborasi antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu. Dalam pelayanan kebidanan, kolaborasi diperlukan untuk memberikan pelayanan yang holistik dan komprehensif.

Bidan masa depan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus mampu berkolaborasi dengan dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, tenaga kesehatan masyarakat, apoteker, hingga tenaga teknologi informasi kesehatan.

Kolaborasi interprofesional membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penanganan komplikasi, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat sistem rujukan kesehatan.

Dalam era digital, collaborative practice juga dapat dilakukan melalui platform digital dan teleconference sehingga koordinasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih mudah dan efektif.

4. Smart Midwifery Care

Smart midwifery care merupakan konsep pelayanan kebidanan modern yang mengintegrasikan teknologi cerdas dalam pelayanan maternal dan neonatal melalui pemanfaatan artificial intelligence, internet of things, dan big data analytics (Sharma et al., 2022). Konsep ini memanfaatkan artificial intelligence, internet of things, big data, dan digital analytics untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Dalam smart midwifery care, data kesehatan pasien dapat dipantau secara real time menggunakan perangkat digital. Sistem dapat memberikan peringatan dini apabila ditemukan tanda bahaya atau risiko komplikasi.

Penggunaan chatbot edukasi kesehatan juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan, nutrisi, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.

Virtual antenatal class menjadi inovasi yang semakin berkembang dalam pelayanan kebidanan. Kelas ibu hamil dapat dilakukan secara online sehingga lebih fleksibel dan mudah diakses.

Smart midwifery care diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

E. Kompetensi Bidan Masa Depan

Perubahan sistem pelayanan kesehatan menuntut bidan untuk memiliki kompetensi yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Bidan masa depan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis, tetapi juga kompetensi digital, komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan.

Salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki adalah digital literacy atau literasi digital sebagai bentuk adaptasi tenaga kesehatan terhadap transformasi pelayanan kesehatan modern (ICM, 2021; WHO, 2021). Bidan harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, memahami penggunaan aplikasi kesehatan, mengoperasikan rekam medis elektronik, serta mampu melakukan konsultasi virtual.

Kemampuan critical thinking dan clinical reasoning juga menjadi kompetensi penting dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan masa depan. Bidan harus mampu menganalisis data kesehatan, mengidentifikasi risiko, serta mengambil keputusan klinis secara tepat berdasarkan evidence based practice.

Kemampuan komunikasi virtual menjadi keterampilan baru yang penting dimiliki oleh bidan. Pelayanan kesehatan digital memerlukan kemampuan komunikasi efektif melalui media online tanpa mengurangi kualitas hubungan terapeutik dengan pasien.

Selain itu, bidan juga harus memiliki kemampuan kolaborasi interprofesional untuk bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif.

Kompetensi cultural competence juga penting dalam pelayanan kebidanan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Bidan harus mampu memberikan pelayanan yang menghargai nilai budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keselamatan pasien.

Untuk mendukung kompetensi bidan masa depan, institusi pendidikan kebidanan perlu melakukan transformasi kurikulum dengan mengintegrasikan digital health, telemidwifery, evidence based practice, artificial intelligence, dan collaborative practice dalam proses pembelajaran.

F. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kebidanan Masa Depan di Indonesia

Transformasi pelayanan kebidanan di era digital menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Rendahnya literasi digital tenaga kesehatan dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi pelayanan kesehatan digital. Sebagian tenaga kesehatan masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan.

Keamanan data pasien menjadi tantangan penting dalam pelayanan kesehatan digital. Penggunaan rekam medis elektronik dan platform online memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi kerahasiaan data pasien.

Selain itu, regulasi terkait telemedicine dan pelayanan kesehatan digital masih terus berkembang di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang jelas terkait standar pelayanan, aspek legal, etika, dan perlindungan pasien.

Meskipun demikian, transformasi pelayanan kebidanan juga memberikan berbagai peluang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, perkembangan teknologi yang cepat, serta dukungan pemerintah terhadap transformasi kesehatan digital.

Perkembangan startup kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan memberikan peluang besar dalam pengembangan pelayanan kebidanan berbasis digital. Selain itu, bonus demografi Indonesia juga menjadi peluang dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang adaptif terhadap teknologi.

G. Strategi Penguatan Pelayanan Kebidanan Masa Depan

Pengembangan pelayanan kebidanan masa depan memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah penguatan kebijakan dan regulasi terkait pelayanan kesehatan digital dan telemidwifery. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi kesehatan terutama di daerah terpencil dan kepulauan agar pelayanan kesehatan digital dapat diakses secara merata.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi pelayanan kebidanan. Bidan perlu diberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi digital, komunikasi virtual, artificial intelligence, dan evidence based practice.

Institusi pendidikan kebidanan juga perlu melakukan inovasi kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan pelayanan kesehatan modern. Mahasiswa kebidanan perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, industri teknologi, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pengembangan pelayanan kebidanan masa depan. Selain itu, riset dan inovasi dalam bidang kebidanan digital perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan

model pelayanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

H. Penutup

Pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia akan mengalami transformasi besar seiring dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan kebutuhan masyarakat. Model pelayanan kebidanan tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan konvensional, tetapi berkembang menuju pelayanan yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan berorientasi pada continuity of care.

Transformasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, efisiensi, dan keselamatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pemanfaatan teknologi seperti telemidwifery, artificial intelligence, rekam medis elektronik, wearable devices, dan aplikasi kesehatan ibu dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Namun demikian, pengembangan pelayanan kebidanan masa depan juga harus tetap mempertahankan nilai humanistik, empati, dan woman centered care. Teknologi tidak boleh menggantikan hubungan terapeutik antara bidan dan pasien, tetapi harus menjadi alat untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.

Continuity of care menjadi fondasi penting dalam pelayanan kebidanan masa depan karena mampu memberikan pelayanan yang holistik, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan neonatal di Indonesia.

Untuk mewujudkan pelayanan kebidanan masa depan yang optimal diperlukan dukungan dari berbagai pihak melalui penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan teknologi kesehatan, penguatan pendidikan kebidanan, serta kolaborasi lintas sektor.

Dengan transformasi yang tepat, pelayanan kebidanan di Indonesia diharapkan mampu menjadi pelayanan yang modern, adaptif, humanis, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kesehatan di era digital.

Referensi

- Aune, I., Dahlberg, U., & Ingebrigtsen, O. (2012). Relational continuity as a model of care in practical midwifery studies. *British Journal of Midwifery*, 20(7), 515–523.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family Nursing: Research, Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- International Confederation of Midwives. (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lee, S. H., Nurmatov, U. B., Nwaru, B. I., Mukherjee, M., Grant, L., & Pagliari, C. (2016). Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 6(1), 010401.
- Ningsih, D. A., & Sari, E. P. (2022). Pemanfaatan telemidwifery dalam pelayanan kebidanan di era digital. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(2), 112–120.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2020). *Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems*. OECD Publishing.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., et al. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2019). Evaluation of a technology-based peer-support intervention program for preventing postnatal depression. *Journal of Medical Internet Research*, 21(8), e12410.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community*. Elsevier.
- Susanto, T. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Aplikasi Teori pada Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Trans Info Media.
- UNICEF. (2021). *Maternal and Newborn Health Disparities in Indonesia*. UNICEF.

- World Health Organization. (2016). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2018). Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021–2025. Geneva: WHO.
- Yanti, Y., Claramita, M., Emilia, O., & Hakimi, M. (2015). Students' understanding of "Women-Centred Care Philosophy" in midwifery care through Continuity of Care (CoC) learning model: A quasi-experimental study. *BMC Nursing*, 14(1), 1–7.

PROFIL PENULIS



Margareta Melani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb., Lahir di Tanung Agung, 05 November 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Stikes Perdaki Charitas (Sekarang Universitas Katolik Musi Charitas Palembang) lulus tahun 2012, melanjutkan pendidikan Sarjana Terapan dan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta lulus tahun 2022. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2025 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 sebagai Bidan di Charitas Hospital KM 7, tahun 2020 sebagai bidan di Charitas Hospital Klepu, tahun 2023 sebagai tenaga kependidikan laboratorium di Universitas Katolik Musi Charitas, dan tahun 2025 sebagai Dosen Tetap di Universitas Katolik Musi Charitas Palembang mengampu mata kuliah Fisiologi dan Metode Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sr.m.louista@ukmc.ac.id

ORCHID ID <https://orcid.org/0009-0002-1493-9812>



Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb., Lahir di Bah Butong pada 18 Agustus 1987.. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik (D4) Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun pada tahun 2014. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan pendidikan Program Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas Padang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Medistra Lubuk Pakam. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam mengampu mata kuliah yang berfokus pada kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikanursaputri@medistra.ac.id

Motto: "Syukur menjadikan hati tenang, sabar menjadikan langkah kuat"

PROFIL PENULIS



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes., Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srinusfiroh052@gmail.com

Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"



Yayuk Puji Lestari, S.ST., Bdn., M.Keb., menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Sari Mulia pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dan lulus pada tahun 2014. Untuk memperdalam keilmuan di bidang kebidanan, penulis menempuh pendidikan Magister Kebidanan (S2) di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Sari Mulia pada tahun 2023. Sejak tahun 2015, penulis aktif sebagai dosen kebidanan dan hingga saat ini mengajar di Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, penulis memiliki ketertarikan pada bidang kehamilan, keselamatan pasien, asuhan kebidanan berbasis bukti, serta pengembangan kompetensi mahasiswa kebidanan. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam penulisan dan publikasi buku ajar serta artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui Email : yayuk.pujilestari1892@gmail.com

Sinopsis

Buku referensi *Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital dan Continuity of Care* membahas perubahan paradigma pelayanan kebidanan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Kehadiran buku ini menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kebidanan yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga mudah diakses, responsif, terintegrasi, serta berpusat pada kebutuhan perempuan, bayi, keluarga, dan masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep Continuity of Care dalam kebidanan, yaitu pendekatan pelayanan yang menekankan kesinambungan asuhan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan asuhan yang komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Continuity of Care juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Selanjutnya, buku ini mengulas perkembangan digital health dan telemidwifery sebagai bagian dari transformasi pelayanan kebidanan di era modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bidan untuk memberikan edukasi, konsultasi, pemantauan, pencatatan, dan komunikasi kesehatan secara lebih efektif. Telemidwifery menjadi salah satu inovasi yang dapat memperluas jangkauan pelayanan kebidanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Buku ini juga membahas pentingnya literasi digital dan kompetensi bidan dalam mendukung praktik kebidanan yang profesional. Bidan perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi, mengelola informasi digital, menjaga kerahasiaan data pasien, menerapkan etika pelayanan, serta memanfaatkan sumber informasi berbasis bukti. Penguatan literasi digital menjadi bagian penting agar bidan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pelayanan kebidanan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan model pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia yang mengintegrasikan pelayanan langsung dengan inovasi digital. Model pelayanan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan geografis, sosial, budaya, dan sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi pelayanan kebidanan perlu diarahkan pada penguatan akses, peningkatan mutu, kolaborasi antarprofesi, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta penerapan asuhan berkesinambungan yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam memahami arah perkembangan pelayanan kebidanan di era digital. Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya integrasi antara teknologi, kompetensi profesional, dan prinsip *Continuity of Care* dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang adaptif, berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan ibu serta anak di Indonesia.

Buku referensi Transformasi Pelayanan Kebidanan di Era Digital dan Continuity of Care membahas perubahan paradigma pelayanan kebidanan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Kehadiran buku ini menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kebidanan yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga mudah diakses, responsif, terintegrasi, serta berpusat pada kebutuhan perempuan, bayi, keluarga, dan masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep Continuity of Care dalam kebidanan, yaitu pendekatan pelayanan yang menekankan kesinambungan asuhan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan asuhan yang komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Continuity of Care juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Selanjutnya, buku ini mengulas perkembangan digital health dan telemidwifery sebagai bagian dari transformasi pelayanan kebidanan di era modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bidan untuk memberikan edukasi, konsultasi, pemantauan, pencatatan, dan komunikasi kesehatan secara lebih efektif. Telemidwifery menjadi salah satu inovasi yang dapat memperluas jangkauan pelayanan kebidanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Buku ini juga membahas pentingnya literasi digital dan kompetensi bidan dalam mendukung praktik kebidanan yang profesional. Bidan perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi, mengelola informasi digital, menjaga kerahasiaan data pasien, menerapkan etika pelayanan, serta memanfaatkan sumber informasi berbasis bukti. Penguatan literasi digital menjadi bagian penting agar bidan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pelayanan kebidanan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan model pelayanan kebidanan masa depan di Indonesia yang mengintegrasikan pelayanan langsung dengan inovasi digital. Model pelayanan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan geografis, sosial, budaya, dan sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi pelayanan kebidanan perlu diarahkan pada penguatan akses, peningkatan mutu, kolaborasi antarprofesi, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta penerapan asuhan berkesinambungan yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam memahami arah perkembangan pelayanan kebidanan di era digital. Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya integrasi antara teknologi, kompetensi profesional, dan prinsip Continuity of Care dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang adaptif, berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan ibu serta anak di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-09-1 (PDF)

